

ACTUALIZACIÓN
02/06/2026

- **Pregunta 33 - respuesta correcta B.**
- **Pregunta 171 - respuesta correcta A.**
- **Pregunta 192 - respuesta correcta C.**
- **Pregunta 4 - respuesta correcta A.**
- **Pregunta 26 - respuesta correcta D.**
- **Pregunta 113 - respuesta correcta C.**
- **Pregunta 145 - respuesta correcta C.**



ASIGNATURA
LEGISLACIÓN
PREGUNTAS COMENTADAS

OPES ENFERMERÍA

Preguntas Osakidetza 2026

Bateria de 200 preguntas comentadas de Legislación

—

SALUSPLAY editorial

CARRETERA BILBAO-PLENCIA 31, OFICINA 111.

48950 ERANDIO, BIZKAIA, PAIS VASCO

TEL.: +34 946522986

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: ERANDIO, 01 DE ABRIL DE 2026

Todos los derechos reservados. Queda prohibido reproducir, almacenar en sistemas de búsqueda automática, realizar copias de todo tipo o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación) o transmitir de otra forma cualquier parte de esta publicación sin la autorización escrita del editor. No se podrá divulgar esta obra en ningún formato.

PREGUNTA 1

DE ACUERDO CON LAS NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS, PARA PODER EJERCER UNA PROFESIÓN SANITARIA SERÁ REQUISITO IMPRESCINDIBLE:

- A. La colegiación, cuando una ley estatal establezca esta obligación para el ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades propias de esta.
- B. La inexistencia de inhabilitación o suspensión para el ejercicio profesional por sentencia judicial, aunque no sea firme, durante el periodo de tiempo que fije esta; por resolución sancionadora impuesta por un colegio profesional sanitario, cuando una ley estatal establezca para este ejercicio la obligación de pertenecer al colegio profesional respectivo durante el periodo de tiempo que fije esta; o por resolución administrativa sancionadora firme, durante el periodo de tiempo que fije esta, cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria pública.
- C. Tener suscrito y vigente un seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera, ya sean de protección personal o colectiva, que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de la responsabilidad profesional por un eventual daño a las personas, causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios, cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria pública.
- D. Todo lo anterior.
- c. No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional por resolución sancionadora impuesta por un colegio profesional sanitario, cuando una ley estatal establezca para este ejercicio la obligación de estar colegiado, durante el periodo de tiempo que fije esta.
- d. No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional, o separado del servicio, por resolución administrativa sancionadora firme, durante el periodo de tiempo que fije esta, cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria pública.
- e. Tener suscrito y vigente un seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera, sean de protección personal o colectiva, que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de la responsabilidad profesional por un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria privada.

PREGUNTA 2

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS, PARA PODER EJERCER UNA PROFESIÓN SANITARIA:

- A. Se ha de tener suscrito y vigente un seguro de responsabilidad que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de la responsabilidad profesional por un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria privada, no siendo suficiente un aval u otra garantía financiera de protección colectiva.
- B. Se ha de tener suscrito y vigente un seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera, sean de protección personal o colectiva, que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de la responsabilidad profesional por un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria privada.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Art.4.8 8. Para el ejercicio de una profesión sanitaria será necesario cumplir las obligaciones y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. En todo caso, para ejercer una profesión sanitaria, serán requisitos imprescindibles:

- a. Estar colegiado, cuando una ley estatal establezca esta obligación para el ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades propias de esta.
- b. No encontrarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio profesional por sentencia judicial firme, durante el periodo de tiempo que fije esta.

- C. Se ha de tener suscrito y vigente un seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera, sean de protección personal o colectiva, que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de la responsabilidad profesional por un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria pública.
- D. Todas las opciones son falsas.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Tener suscrito y vigente un seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera, sean de protección personal o colectiva, que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de la responsabilidad profesional por un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria privada.

PREGUNTA 3

SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE, EL ÓRGANO ENCARGADO DEL REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS PODRÁ (INDÍQUESE LA QUE SEA CORRECTA):

- A. Consultar los datos de carácter personal de la población profesional sanitaria contenidos en los archivos y ficheros del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del Número de Identidad de Extranjero (NIE) competencia del Ministerio del Interior, para contrastar la veracidad de la información que consta en el registro.
- B. Consultar los datos de carácter personal de la población profesional sanitaria contenidos en los archivos y ficheros del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del Número de Identidad de Extranjero (NIE) competencia del Ministerio del Interior, para contrastar la veracidad de la información que consta en el registro, pero solo si la persona titular no se ha opuesto explícitamente.
- C. Consultar los datos de carácter personal de los profesionales sanitarios contenidos en los archivos y ficheros del Documento Nacional

de Identidad (DNI) y del Número de Identidad de Extranjero (NIE) competencia del Ministerio del Interior, para contrastar la veracidad de la información que consta en el registro, pero solo si el titular de los datos da su consentimiento expreso.

- D. Solo podrá consultar los datos de carácter personal de la población profesional sanitaria contenidos en los archivos y ficheros del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del Número de Identidad de Extranjero (NIE) en el curso de una investigación sobre una infracción administrativa.

Respuesta correcta: A

Comentario:

El órgano encargado del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios podrá consultar los datos de carácter personal de los profesionales sanitarios contenidos en los archivos y ficheros del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del Número de Identidad del Extranjero (NIE) competencia del Ministerio del Interior, para contrastar la veracidad de la información que consta en el registro. Para esta consulta no será necesario el consentimiento del titular de los datos de carácter personal.

PREGUNTA 4

EN EL MARCO DE LA ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS, LAS PERSONAS PACIENTES:

- A. Tienen derecho a la libre elección del personal facultativo que debe atenderles, tanto si su ejercicio profesional se desarrolla en el sistema público como en el ámbito privado.
- B. Tienen derecho a la libre elección del personal facultativo que debe atenderles, pero solo si su ejercicio profesional se desarrolla en el sistema público.
- C. Tienen derecho a la libre elección del personal facultativo que debe atenderles, pero solo si su ejercicio profesional se desarrolla en el ámbito privado.
- D. Ninguna de las anteriores es correcta.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Los pacientes tienen derecho a la libre elección del médico que debe atenderles. Tanto si el ejercicio profesional se desarrolla en el sistema público como en el ámbito privado por cuenta ajena, este derecho se ejercitará de acuerdo con una normativa explícita que debe ser públicamente conocida y accesible. En esta situación el profesional puede ejercer el derecho de renunciar a prestar atenciones sanitarias a dicha persona sólo si ello no conlleva desatención. En el ejercicio en el sistema público o privado, dicha renuncia se ejercerá de acuerdo con procedimientos regulares, establecidos y explícitos, y de ella deberá quedar constancia formal.

PREGUNTA 5

SEGÚN LA NORMATIVA DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS, EL PERSONAL PROFESIONAL Y LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS CENTROS SANITARIOS FACILITARÁN A SUS PACIENTES EL EJERCICIO DEL DERECHO A CONOCER:

- A. El nombre, la titulación, la especialidad y la hoja de servicios del personal sanitario que les atiende, así como la categoría y función de dicho personal, si así estuvieran definidas en su centro o institución.
- B. El nombre, la titulación y la especialidad del personal sanitario que les atiende y su categoría, pero no su función en su centro o institución.
- C. El nombre, la titulación y la especialidad del personal sanitario que les atiende, así como la categoría y función de dicho personal, si así estuvieran definidas en su centro o institución.
- D. El nombre, la titulación y la especialidad del personal sanitario que les atiende, pero no su categoría y función en su centro o institución.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Los profesionales y los responsables de los centros sanitarios facilitarán a sus pacientes el ejercicio del derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los profesionales sanitarios que les atienden, así como a conocer la categoría y función de éstos, si así estuvieran definidas en su centro o institución.

PREGUNTA 6

DE ACUERDO CON LAS NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS, EL EJERCICIO DEL DERECHO DEL PERSONAL PROFESIONAL SANITARIO A LA RENUNCIA A LA ATENCIÓN A UNA PERSONA PACIENTE QUEDA CONDICIONADO A QUE (SEÑÁLESE LA RESPUESTA INCORRECTA):

- A. Su renuncia no conlleva desatención de la persona paciente.
- B. La renuncia se ejerza de acuerdo con procedimientos regulares.
- C. Quede constancia, aunque no sea formal, de la renuncia.
- D. La renuncia se ejerza de acuerdo con procedimientos establecidos y explícitos.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Los pacientes tienen derecho a la libre elección del médico que debe atenderles. Tanto si el ejercicio profesional se desarrolla en el sistema público como en el ámbito privado por cuenta ajena, este derecho se ejercitará de acuerdo con una normativa explícita que debe ser públicamente conocida y accesible. En esta situación el profesional puede ejercer el derecho de renunciar a prestar atenciones sanitarias a dicha persona sólo si ello no conlleva desatención. En el ejercicio en el sistema público o privado, dicha renuncia se ejercerá de acuerdo con procedimientos regulares, establecidos y explícitos, y de ella deberá quedar constancia formal.

PREGUNTA 7

LOS CENTROS SANITARIOS REVISARÁN QUE EL PERSONAL SANITARIO DE SU PLANTILLA CUMPLE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS Y EN LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES:

- A. Cada cinco años como mínimo.
- B. Cada tres años como mínimo.
- C. Cada dos años como mínimo.
- D. Cada cuatro años como mínimo.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Art. 8 Los centros sanitarios revisarán, cada tres años como mínimo, que los profesionales sanitarios de su plantilla cumplen los requisitos necesarios para ejercer la profesión.

PREGUNTA 8

SEGÚN DISPONE LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS, CUANDO UNA ACTUACIÓN SANITARIA SE REALICE POR UN EQUIPO DE PROFESIONALES (SEÑÁLESE LA RESPUESTA INCORRECTA):

- A. Se articulará, preferentemente, de forma jerarquizada, atendiendo a los criterios de conocimientos y competencia y, en su caso, al de titulación del personal profesional que integra el equipo, en función de la actividad concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento recíproco de las capacidades de quienes forman el equipo, y de los principios de accesibilidad y continuidad asistencial de las personas atendidas.
- B. Se articulará de forma jerarquizada o colegiada, atendiendo a los criterios de conocimientos y competencia y, en su caso, al de titulación del personal profesional que integra el equipo, en función de la actividad concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento recíproco de las capacidades de quienes forman el equipo, y de los principios de accesibilidad y continuidad asistencial de las personas atendidas.
- C. Se articulará de forma preferentemente colegiada, atendiendo a los criterios de conocimientos y competencia y, en su caso, al de titulación del personal profesional que integra el equipo, en función de la actividad concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento recíproco de las capacidades de quienes forman el equipo, y de los principios de accesibilidad y continuidad asistencial de las personas atendidas.
- D. Ninguna de las anteriores es correcta.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Cuando una actuación sanitaria se realice por un equipo de profesionales, se articulará de forma je-

rarquizada o colegiada, en su caso, atendiendo a los criterios de conocimientos y competencia, y en su caso al de titulación, de los profesionales que integran el equipo, en función de la actividad concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento recíproco de las capacidades de sus miembros, y de los principios de accesibilidad y continuidad asistencial de las personas atendidas.

PREGUNTA 9

DE ACUERDO CON LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS, DIGA CUÁL DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS GENERALES DE LA RELACIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE EJERCEN PROFESIONES SANITARIAS Y LAS PERSONAS ATENDIDAS NO ES TAL:

- A. El personal profesional tiene el deber de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, tomando en consideración, entre otros, los costes de sus decisiones y evitando la sobreutilización, la infrautilización y la inadecuada utilización de los mismos.
- B. El personal profesional tiene el deber de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atiende, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en esta ley y el resto de normas legales y deontológicas aplicables.
- C. El personal profesional tiene el deber de proporcionar a las personas pacientes información precisa sobre su formación profesional, la forma en que han actualizado sus conocimientos y las demandas de responsabilidad que hayan podido derivar en responsabilidades administrativas.
- D. El personal profesional tiene el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado y debe respetar su participación en las tomas de decisiones que les afecten. En todo caso, deben ofrecer una información suficiente y adecuada para que puedan ejercer su derecho al consentimiento sobre dichas decisiones.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Los profesionales y los responsables de los centros sanitarios facilitarán a sus pacientes el ejercicio del derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los profesionales sanitarios que les atienden, así como a conocer la categoría y función de éstos, si así estuvieran definidas en su centro o institución. Las demás respuestas aparecen como principios de la relación del profesional sanitario y el paciente en el art. 5.

PREGUNTA 10

DE ACUERDO CON LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS, LOS CENTROS SANITARIOS ACREDITADOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUADA:

- A. Deberán contar con jefaturas de estudios, con la coordinación docente y con el personal tutor de la formación que resulten adecuados en función de las actividades a desarrollar, así como con una figura de defensoría del alumnado.
- B. Deberán contar una comisión de docencia, así como con jefaturas de estudios, coordinación docente y personal tutor de la formación que resulten adecuados en función de las actividades a desarrollar.
- C. Deberán contar una comisión de docencia y con una figura de defensoría del alumnado, así como con jefaturas de estudios, coordinación docente y personal tutor de la formación que resulten adecuados en función de las actividades a desarrollar.
- D. Todas las anteriores son incorrectas.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Los centros sanitarios acreditados para la formación especializada deberán contar con una comisión de docencia y los jefes de estudios, coordinadores docentes y tutores de la formación que resulten adecuados en función de su capacidad docente, en la forma que se prevé en el título II de esta ley.

Los centros sanitarios acreditados para desarrollar programas de formación continuada deberán con-

tar con los jefes de estudios, coordinadores docentes y tutores de la formación que resulten adecuados en función de las actividades a desarrollar.

PREGUNTA 11

SEGÚN DISPONE LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, SUS DISPOSICIONES SE APLICARÁN A:

- A. A los servicios sanitarios de financiación pública y a los privados, en los mismos términos.
- B. A los servicios sanitarios de financiación pública. También a los privados en lo que se refiere al control de las actividades de salud pública y en materia de garantías de información, seguridad y calidad.
- C. A los servicios sanitarios de financiación pública y a los privados concertados.
- D. Únicamente a los servicios sanitarios de financiación pública.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Lo dispuesto en esta ley será de aplicación a los servicios sanitarios de financiación pública y a los privados en los términos previstos en el artículo 6 y en las disposiciones adicionales tercera y cuarta (art.6 en relación con las actividades de salud pública y en materia de garantías de información, seguridad y calidad).

PREGUNTA 12

SEGÚN DISPONE LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, LA CIUDADANÍA TENDRÁ LOS SIGUIENTES DERECHOS EN EL CONJUNTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD:

- A. A recibir asistencia sanitaria en su comunidad autónoma de residencia.
- B. A recibir el reembolso de los gastos derivados de la asistencia en la sanidad privada cuando se trate de servicios recogidos en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
- C. A recibir el reembolso de los gastos derivados de la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud

que pudiera requerir del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado/a.

D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Artículo 4. Derechos de los ciudadanos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. En los términos de esta ley, los ciudadanos tendrán los siguientes derechos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud: b) A recibir asistencia sanitaria en su comunidad autónoma de residencia en un tiempo máximo, en los términos del artículo 25.

Aunque a esa respuesta le falte en un tiempo máximo, el concepto principal del derecho a recibir asistencia sanitaria en la CCAA de residencia sí aparece.

PREGUNTA 13

SEGÚN DISPONE LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, LA CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD SE ARTICULA EN TORNO A LAS SIGUIENTES MODALIDADES:

- A. Cartera común básica de servicios asistenciales, cartera común suplementaria y cartera común de servicios accesorios.
- B. Cartera común básica nacional de servicios asistenciales y cartera común autonómica de servicios asistenciales.
- C. Cartera común nacional básica de servicios asistenciales, cartera común suplementaria autonómica y cartera común de servicios accesorios autonómicos.
- D. Cartera común nacional y autonómica básica de servicios asistenciales, cartera común nacional y autonómica suplementaria y cartera común nacional y autonómica de servicios accesorios.

Respuesta correcta: A

Comentario:

La cartera de servicios del SNS se estructura en: cartera común básica de servicios asistenciales,

cartera común suplementaria y cartera común de servicios accesorios (Ley 16/2003, art. 8 bis).

PREGUNTA 14

SEGÚN DISPONE LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, LA CARTERA COMÚN BÁSICA DE SERVICIOS ASISTENCIALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD COMPRENDE:

- A. Todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o socio-sanitarios, así como el transporte sanitario urgente, la prestación farmacéutica y la prestación ortoprotésica, cubiertos de forma completa por financiación pública.
- B. Todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o socio-sanitarios, así como el transporte sanitario urgente y la prestación farmacéutica, cubiertos de forma completa por financiación pública.
- C. Todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o socio-sanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y la prestación ortoprotésica, cubiertos de forma completa por financiación pública.
- D. Todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o socio-sanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por financiación pública.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Art. 8 La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud comprende todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por financiación pública.

PREGUNTA 15

SEGÚN DISPONE LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, LA CARTERA COMÚN SUPLEMENTARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD INCLUIRÁ LAS SIGUIENTES PRESTACIONES:

- A. Únicamente la prestación farmacéutica.
- B. Únicamente la prestación ortoprotésica.
- C. Únicamente la prestación farmacéutica y la prestación ortoprotésica.
- D. La prestación farmacéutica, la prestación ortoprotésica y la prestación con productos dietéticos.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Esta cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud incluirá las siguientes prestaciones:

- a. Prestación farmacéutica.
- b. Prestación ortoprotésica.
- c. Prestación con productos dietéticos.

También gozará de esta consideración el transporte sanitario no urgente, sujeto a prescripción facultativa, por razones clínicas y con un nivel de aportación del usuario acorde al determinado para la prestación farmacéutica.

PREGUNTA 16

SEGÚN DISPONE LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA NO COMPRENDERÁ:

- A. La atención a la salud bucodental.
- B. La atención paliativa a personas enfermas terminales.
- C. La rehabilitación básica.
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Al preguntar cuál prestación no comprenderá, todas son falsas, ya que todas las respuestas están comprendidas en atención primaria atención primaria comprenderá:

- a. La asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo.
- b. La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
- c. Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención comunitaria.
- d. Las actividades de información y vigilancia en la protección de la salud.
- e. La rehabilitación básica.
- f. Las atenciones y servicios específicos relativos a las mujeres, que específicamente incluirán la detección y tratamiento de las situaciones de violencia de género; la infancia; la adolescencia; los adultos; la tercera edad; los grupos de riesgo y los enfermos crónicos.
- g. La atención paliativa a enfermos terminales.
- h. La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios de atención especializada.
- i. La atención a la salud bucodental.

PREGUNTA 17

SEGÚN DISPONE LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD:

- A. Es preceptivo el informe favorable de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, en relación con la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así como su impacto económico y organizativo.
- B. Se contará con la participación de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, en la evaluación de la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos

menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así como su impacto económico y organizativo.

- C. Es preceptivo el informe favorable de las sociedades científicas implicadas, en relación con la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así como su impacto económico y organizativo.
- D. Se contará con la participación de las sociedades científicas implicadas, en la evaluación de la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así como su impacto económico y organizativo.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Art. 20. El contenido de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se determinará por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación. En la elaboración de dicho contenido se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así como su impacto económico y organizativo.

En la evaluación de lo dispuesto en el párrafo anterior participará la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

PREGUNTA 18

SEGÚN DISPONE LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, LA EXCLUSIÓN DE UNA TÉCNICA, TECNOLOGÍA O PROCEDIMIENTO ACTUALMENTE INCLUIDO EN LA CARTERA DE SERVICIOS SE LLEVARÁ A CABO CUANDO:

- A. Se evidencie su falta de eficacia, efectividad o eficiencia, o que el balance entre beneficio y riesgo sea significativamente desfavorable.
- B. Requiera una formación para la que no exista la especialidad médica correspondiente.
- C. Hayan cambiado las condiciones económicas de su implantación.
- D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Art. 21 La exclusión de una técnica, tecnología o procedimiento actualmente incluido en la cartera de servicios se llevará a cabo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a. Evidenciarse su falta de eficacia, efectividad o eficiencia, o que el balance entre beneficio y riesgo sea significativamente desfavorable.
- b. Haber perdido su interés sanitario como consecuencia del desarrollo tecnológico y científico.
- c. Dejar de cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente.

PREGUNTA 19

A LOS EFECTOS DE LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, LA COMPETENCIA PROFESIONAL ES:

- A. La acreditación de formación continuada a lo largo del desempeño de su carrera profesional.
- B. La competencia acreditada por el título correspondiente acreditativo de la adquisición de conocimientos requeridos para el desempeño del puesto designado.
- C. La aptitud del personal profesional sanitario para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión para resolver los problemas que se le plantean.
- D. La superación del proceso selectivo oficial convocado por la autoridad competente para la adquisición del vínculo estatutario con los servicios sanitarios.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Art. 42 la competencia profesional es la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión para resolver los problemas que se le plantean.

PREGUNTA 20

SEGÚN DISPONE LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, LA DECLARACIÓN DE ACTUACIONES COORDINADAS EN SALUD PÚBLICA Y EN SEGURIDAD ALIMENTARIA DEBERÁN ENCUADRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- A. Responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública.
- B. Establecer planes preventivos para hacer frente a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública.
- C. Realizar análisis epidemiológicos que permitan establecer estructuras y recursos según las previsiones en materia de salud pública y seguridad alimentaria.
- D. Las respuestas a) y b) son verdaderas y la c) es falsa.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Art. 65. La declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las partes incluidas en ella y deberán encuadrarse en alguno de los supuestos siguientes:

- 1. Responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública.
- 2. Dar cumplimiento a acuerdos internacionales, así como a programas derivados de las exigencias de la normativa emanada de la Unión Europea, cuando su cumplimiento y desarrollo deba ser homogéneo en todo el Estado. Para la realización de las actuaciones coordinadas podrá acudir, entre otros, a los siguientes mecanismos:
 - a. Utilización común de instrumentos técnicos.
 - b. Coordinación y refuerzo de la Red de Laboratorios de Salud Pública.
 - c. Definición de estándares mínimos para el análisis e intervención sobre problemas de salud.

- d. Refuerzo de los sistemas de información epidemiológica para la toma de decisiones y de los correspondientes programas de promoción, prevención y control de enfermedades, cuando sus efectos trasciendan el ámbito autonómico.
- e. Activación o diseño de planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias.

PREGUNTA 21

SEGÚN DISPONE LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, LA ORDENACIÓN DEL RÉGIMEN PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SE RIGE POR UNA SERIE DE PRINCIPIOS Y CRITERIOS. SEÑALE CUALES NO ESTÁN ENTRE LOS MENCIONADOS POR ESTA LEY:

- A. Sometimiento pleno a la ley y el derecho.
- B. Igualdad, mérito, capacidad y promoción en el acceso a la condición de personal estatutario.
- C. Integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus centros e instituciones.
- D. Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administraciones sanitarias públicas.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Artículo 4. Principios y criterios de ordenación del régimen estatutario. La ordenación del régimen del personal estatutario de los servicios de salud se rige por los siguientes principios y criterios:

- a. Sometimiento pleno a la ley y el derecho.
- b. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal estatutario.
- c. Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento de la condición de personal estatutario fijo.
- d. Libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
- e. Responsabilidad en el ejercicio profesional y objetividad como garantías de la competencia e imparcialidad en el desempeño de las funciones.
- f. Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las convocatorias.

- g. Integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus centros e instituciones.
- h. Incorporación de los valores de integridad, neutralidad, transparencia en la gestión, deontología y servicio al interés público y a los ciudadanos, tanto en la actuación profesional como en las relaciones con los usuarios.
- i. Dedicación prioritaria al servicio público y transparencia de los intereses y actividades privadas como garantía de dicha preferencia.
- j. Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administraciones sanitarias públicas.
- k. Participación de las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo, a través de la negociación en las mesas correspondientes.

PREGUNTA 22

LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO SE ADQUIERE, TAL Y COMO PREVÉ LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- A. Incorporación a una plaza de servicio, institución o centro que corresponda en el plazo fijado en la convocatoria tras la superación de las pruebas de selección.
- B. Superación de las pruebas de selección; nombramiento conferido por el órgano competente; e incorporación a una plaza del servicio, institución o centro que corresponda en el plazo de un mes.
- C. Superación de las pruebas de selección; nombramiento conferido por el órgano competente; e incorporación, previo cumplimiento de los requisitos formales en cada caso establecidos, a una plaza del servicio, institución o centro que corresponda en el plazo determinado en la convocatoria.
- D. Superación de las pruebas de selección; nombramiento conferido por el órgano competente; e incorporación a una plaza del servicio, institución o centro que corresponda en todo caso en el plazo determinado en la convocatoria.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Artículo 20. Adquisición de la condición de personal estatutario fijo.

1. La condición de personal estatutario fijo se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:
 - a. Superación de las pruebas de selección.
 - b. Nombramiento conferido por el órgano competente.
 - c. Incorporación, previo cumplimiento de los requisitos formales en cada caso establecidos, a una plaza del servicio, institución o centro que corresponda en el plazo determinado en la convocatoria.

PREGUNTA 23

SEGÚN DICE LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO, NO PODRÁN RECIBIR NOMBRAMIENTO Y QUEDARÁN SIN EFECTO LAS ACTUACIONES DE QUIENES:

- A. No acrediten que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, una vez superado el proceso selectivo.
- B. No acrediten que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, con carácter previo a la superación del proceso selectivo.
- C. No acrediten que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, una vez firmada la convocatoria.
- D. Una vez superado el proceso selectivo, automáticamente se procede al nombramiento por el órgano competente.

Respuesta correcta: A

Comentario:

A efectos de lo dispuesto en el párrafo b) del apartado anterior, no podrán ser nombrados, y quedarán sin efecto sus actuaciones, quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.

PREGUNTA 24

LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO REGULADA EN LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, SE PRODUCE:

- A. Siempre en caso de pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, afecte o no al correspondiente nombramiento.
- B. En caso de que se adopte la pena de inhabilitación absoluta sea firme o no.
- C. En caso de que se adopte la pena de inhabilitación especial para la correspondiente profesión, siempre que esta exceda de seis años.
- D. En caso de que se adopte la pena de inhabilitación especial para la correspondiente profesión, siempre que esta exceda de tres años.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Artículo 25. Penas de inhabilitación absoluta o especial. La pena de inhabilitación absoluta, cuando hubiera adquirido firmeza, produce la pérdida de la condición de personal estatutario. Igual efecto tendrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público si afecta al correspondiente nombramiento.

Supondrá la pérdida de la condición de personal estatutario la pena de inhabilitación especial para la correspondiente profesión, siempre que esta exceda de seis años.

PREGUNTA 25

CONFORME A LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, SEÑALE CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA:

- A. La jubilación puede ser forzosa o voluntaria.
- B. Para que la persona interesada pueda prolongar su permanencia en servicio activo hasta cumplir los 70 años, bastará con que lo solicite voluntariamente.
- C. La jubilación forzosa se declarará al cumplir la persona interesada 65 años.

- D. Podrá optar a la jubilación voluntaria, total o parcial, el personal estatutario que reúna los requisitos establecidos en la legislación de Seguridad Social.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Art. 26. El interesado podrá solicitar voluntariamente prolongar su permanencia en servicio activo hasta cumplir, como máximo, los 70 años de edad, siempre que quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento. Esta prolongación deberá ser autorizada por el servicio de salud correspondiente, en función de las necesidades de la organización articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos humanos.

PREGUNTA 26

PROCEDE LA EXTINCIÓN DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LOS SERVICIOS DE SALUD:

- A. Cuando se produzca la pérdida de la nacionalidad.
- B. En caso de recaer sanción firme disciplinaria de separación del servicio.
- C. Siempre que se imponga una pena principal o accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público o para el ejercicio de la correspondiente profesión.
- D. Todas las anteriores respuestas son correctas.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Artículo 21. Pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Son causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo:

- a. La renuncia.
- b. La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento.
- c. La sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
- d. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta y, en su caso, la especial para empleo o cargo público o para el ejercicio de la correspondiente profesión.

- e. La jubilación.
- f. La incapacidad permanente, en los términos previstos en esta ley.

PREGUNTA 27

EN MATERIA DE RETRIBUCIONES, LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PREVE QUE:

- A. El sistema retributivo del personal estatutario se estructura en retribuciones básicas y retribuciones complementarias.
- B. La evaluación del personal estatutario a efectos de determinación de una parte de la retribuciones complementarias se establecerá a través de procedimientos fundados en los principios igualdad, objetividad y transparencia.
- C. El sistema retributivo del personal estatutario responde a los principios de cualificación técnica y profesional.
- D. Todas las respuestas son correctas.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Art. 41.1. El sistema retributivo del personal estatutario se estructura en retribuciones básicas y retribuciones complementarias, responde a los principios de cualificación técnica y profesional y asegura el mantenimiento de un modelo común en relación con las retribuciones básicas. Elemento fundamental en este apartado es, en cualquier caso, la evaluación del desempeño del personal estatutario que los servicios de salud deberán establecer a través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad y transparencia. La evaluación periódica deberá tenerse en cuenta a efectos de determinación de una parte de estas retribuciones complementarias.

PREGUNTA 28

DE ACUERDO CON LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA RESPECTO A LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD:

- A. Las retribuciones básicas son: el sueldo asignado a cada categoría en función del título exigido para su desempeño; los trienios; y las pagas extraordinarias.
- B. Las retribuciones básicas serán iguales en todos los servicios de salud independientemente de la anualidad en la que se perciban.
- C. El personal estatutario temporal percibirá la totalidad de las retribuciones que, en el correspondiente servicio de salud, correspondan a su nombramiento, con excepción del complemento de carrera.
- D. El complemento de atención continuada está destinado a retribuir la iniciativa continuada y permanente de la persona titular del puesto.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Artículo 42. Retribuciones básicas.

1. Las retribuciones básicas son:
 - a. El sueldo asignado a cada categoría en función del título exigido para su desempeño conforme a lo previsto en los artículos 6.2 y 7.2 de esta ley.
 - b. Los trienios, que consisten en una cantidad determinada para cada categoría en función de lo previsto en el párrafo anterior, por cada tres años de servicios. La cuantía de cada trienio será la establecida para la categoría a la que pertenezca el interesado el día en que se perfeccionó.
 - c. Las pagas extraordinarias serán dos al año y se devengarán preferentemente en los meses de junio y diciembre. El importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una mensualidad del sueldo y trienios, al que se añadirá la catorceava parte del importe anual del complemento de destino.
2. Las retribuciones básicas y las cuantías del sueldo y los trienios a que se refiere el apartado anterior serán iguales en todos los servicios de salud y se determinarán, cada año, en las correspondientes Leyes de Presupuestos. Dichas cuantías de sueldo y trienios coincidirán igualmente con las establecidas cada año en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los funcionarios públicos.

PREGUNTA 29

LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SE PRODUCE CUANDO LA INCAPACIDAD PERMANENTE SEA DECLARADA:

- A. En grado de incapacidad permanente total para la profesión habitual.
- B. En grado de incapacidad absoluta para todo trabajo.
- C. En grado de gran invalidez.
- D. Todas las respuestas son correctas.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Artículo 27. Incapacidad permanente. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez conforme a las normas reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social, produce la pérdida de la condición de personal estatutario.

PREGUNTA 30

EN EL SUPUESTO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD:

- A. El período de localización es aquel período de tiempo en el que el personal se encuentra únicamente en situación de disponibilidad.
- B. Se considera período de descanso todo período de tiempo que no sea tiempo de trabajo.
- C. El trabajo por turnos es una forma de organización del trabajo en equipo con arreglo al ritmo rotatorio y siempre de tipo continuo.
- D. El período de localización es aquel período de tiempo en el que el personal se encuentra en situación de disponibilidad a los solos efectos de asegurar su posible localización.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Art. 46. d) Período de localización: período de tiempo en el que el personal se encuentra en situación de disponibilidad que haga posible su localización y presencia inmediata para la prestación de un trabajo o

servicios efectivo cuando fuera llamado para atender las necesidades asistenciales que eventualmente se puedan producir e) Período de descanso: todo período de tiempo que no sea tiempo de trabajo h) Trabajo por turnos: toda forma de organización del trabajo en equipo por la que el personal ocupe sucesivamente las mismas plazas con arreglo a un ritmo determinado, incluido el ritmo rotatorio, que podrá ser de tipo continuo o discontinuo, implicando para el personal la necesidad de realizar su trabajo en distintas horas a lo largo de un período dado de días o de semanas.

PREGUNTA 31

PARA EL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EL PERÍODO NOCTURNO TENDRÁ LA SIGUIENTE DURACIÓN:

- A. Mínima de siete horas e incluirá necesariamente el período comprendido entre las cero y las cinco horas de cada día natural.
- B. Mínima de ocho horas e incluirá necesariamente el período comprendido entre las cero y las cinco horas de cada día natural.
- C. Mínima de ocho horas e incluirá necesariamente el período comprendido entre las doce y las cinco horas de cada día natural.
- D. Mínima de siete horas e incluirá necesariamente el período comprendido entre las doce y las cinco horas de cada día natural.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Art. 46. f) Período nocturno: el período nocturno se definirá en las normas, pactos o acuerdos que sean aplicables a cada centro sanitario. Tendrá una duración mínima de siete horas e incluirá necesariamente el período comprendido entre las cero y las cinco horas de cada día natural.

PREGUNTA 32

SEGÚN ESTABLECE LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD:

- A. Resulta incompatible para el personal estatutario de los servicios de salud el ejercicio de las funciones sanitarias con cualquier otro tipo de funciones.

- B. Al personal estatutario de los servicios de salud le resulta aplicable el mismo régimen de incompatibilidades establecido para el personal funcionario.
- C. Atendiendo a lo que establezca la legislación vigente, el personal estatutario de los servicios de salud podrá compatibilizar las funciones sanitarias y docente.
- D. Para el personal licenciado sanitario el complemento específico resulta irrenunciable.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Artículo 76. Régimen general. Resultará de aplicación al personal estatutario el régimen de incompatibilidades establecido con carácter general para los funcionarios públicos, con las normas específicas que se determinan en esta ley. En relación al régimen de compatibilidad entre las funciones sanitarias y docentes, se estará a lo que establezca la legislación vigente. En el ámbito de cada servicio de salud se establecerán las disposiciones oportunas para posibilitar la renuncia al complemento específico por parte del personal licenciado sanitario.

PREGUNTA 33

LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD REGULA EL DESCANSO SEMANAL. SEÑALE LA RESPUESTA QUE NO ES CORRECTA:

- A. El personal tendrá derecho a un período mínimo que siempre será fijo de descanso ininterrumpido con una duración media de 24 horas semanales.
- B. El período de referencia para el cálculo del período de descanso semanal será de tres meses.
- C. En el caso de que no se hubiera disfrutado del tiempo mínimo de descanso semanal en el período de tres meses se producirá una compensación a través del régimen de descansos alternativos.
- D. El período de referencia para el cálculo del período de descanso semanal será de dos meses.

Respuesta correcta: B

Comentario:

La opción B afirma que el período de referencia es de tres meses, cuando el artículo 52 de la Ley 55/2003 establece expresamente dos meses. Es el error más directo y falsable del enunciado. La pregunta podría ser impugnada, pero si cae, es la que tenemos que responder.

PREGUNTA 34

CONFORME A LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD:

- A. El personal tendrá derecho a una vacación retribuida cuya duración no será inferior en ningún caso a 30 días naturales.
- B. El personal estatutario de los servicios de salud podrá elegir sustituir el período de vacación por una compensación económica.
- C. Solo podrá ser sustituido por una compensación económica el período vacacional anual mediante la programación funcional de los centros, cuando así lo aconsejen razones organizativas.
- D. Anualmente, el personal tendrá derecho a una vacación retribuida cuya duración no será inferior a 30 días naturales, o al tiempo que proporcionalmente corresponda en función del tiempo de servicios.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Artículo 53. Vacaciones anuales.

- 1. Anualmente, el personal tendrá derecho a una vacación retribuida cuya duración no será inferior a 30 días naturales, o al tiempo que proporcionalmente corresponda en función del tiempo de servicios.

PREGUNTA 35

LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA SOLICITADA POR EL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD POR INTERÉS PARTICULAR EXIGE HABER PRESTADO SERVICIOS EFECTIVOS EN CUALQUIERA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DURANTE:

- A. Los cinco años inmediatamente anteriores.
- B. Los cuatro años inmediatamente anteriores.

- C. Los dos años inmediatamente anteriores.
- D. Los tres años inmediatamente anteriores.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Artículo 67. Excedencia voluntaria.

1. La situación de excedencia voluntaria se declarará de oficio o a solicitud del interesado, según las reglas siguientes:
 - a. Podrá concederse la excedencia voluntaria al personal estatutario cuando lo solicite por interés particular. Para obtener el pase a esta situación será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores.

PREGUNTA 36

LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI, ESTABLECE QUE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA VASCA DEBE GARANTIZAR LA TUTELA GENERAL DE LA SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

- A. Medidas preventivas.
- B. Promoción de la salud.
- C. Prestaciones sanitarias individuales.
- D. Son correctas todas las respuestas.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Artículo 3. Actuaciones que corresponden a la Administración sanitaria vasca. De acuerdo con las obligaciones que impone a los poderes públicos vascos el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, compete a la Administración sanitaria vasca garantizar la tutela general de la salud pública a través de medidas preventivas, de promoción de la salud y de prestaciones sanitarias individuales.

PREGUNTA 37

LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI, RECONOCE LA UNIVERSALIDAD DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PARA:

- A. Todas las personas residentes en el territorio de Euskadi, así como para las personas transeúntes.
- B. Todas las personas residentes en Euskadi o fuera de Euskadi, así como para las personas transeúntes.
- C. Solo para las personas que tengan vecindad administrativa en Euskadi.
- D. Solo para las personas de quienes pueda predicarse la condición política de vascos.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Artículo 4. Ámbito subjetivo y contenido material del derecho a la protección de la salud en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 1. El derecho a la protección de la salud tiene carácter universal en el territorio de Euskadi para todas las personas residentes, así como para las transeúntes, en la forma y condiciones previstas en la legislación general, en los convenios de colaboración e internacionales que resulten de aplicación y en los términos establecidos en los apartados siguientes.

PREGUNTA 38

SEÑALE CUÁL DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS NO SE ENUNCIAN ENTRE LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI EN LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI:

- A. Universalidad.
- B. Solidaridad ciudadana.
- C. Equidad.
- D. Calidad de los servicios.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Artículo 6. Principios informadores. Informan el sistema sanitario de Euskadi los principios de universalidad, solidaridad, equidad, calidad de los servicios y participación ciudadana.

PREGUNTA 39

LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI, ESTABLECE RESPECTO A LAS ÁREAS DE SALUD QUE:

- A. La Comunidad Autónoma del País Vasco se divide territorialmente en áreas de salud de acuerdo con la situación socio-económica de cada demarcación geográfica.
- B. En cada área de salud pueden ponerse en práctica las actuaciones esenciales que requiere la tutela general de la salud pública y exclusivamente la asistencia sanitaria primaria.
- C. En cada área de salud se garantizará una adecuada ordenación de la atención primaria y su coordinación con la atención especializada.
- D. Son correctas la a) y la c).

Respuesta correcta: C

Comentario:

Artículo 7. Ordenación territorial del sistema.

1. La planificación sanitaria tendrá como base principal de ordenación territorial la división de todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi en las demarcaciones geográficas denominadas áreas de salud, que serán delimitadas reglamentariamente de acuerdo con la situación socio-sanitaria, de manera que puedan ponerse en práctica en su respectivo ámbito los principios y objetivos que enumera esta ley, así como las actuaciones esenciales que requieren la tutela general de la salud pública y la asistencia sanitaria primaria y especializada.
2. En el ámbito de cada área de salud se podrá señalar la ordenación territorial inferior que resulte necesaria en función de cada circunstancia territorial y, en su caso, para cada tipología de prestaciones y servicios sanitarios. En cada área se garantizará una adecuada ordenación de la atención primaria y su coordinación con la atención especializada.

PREGUNTA 40

LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI PREVE LA CREACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN NECESARIOS PARA FACILITAR EL EJERCICIO ADECUADO DE LOS DISTINTOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA. A TAL FIN, LOS DATOS DE CARÁCTER

PERSONAL RELATIVOS A LA SALUD PODRÁN SER RECABADOS Y TRATADOS SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- A. Siempre debe constar el previo consentimiento de la persona afectada.
- B. Si no consta el previo consentimiento de la persona afectada se requiere que la actuación se encuentre debidamente autorizada y se efectúe previo procedimiento de disociación que garantice el anonimato de la información.
- C. Que conste el previo consentimiento de la persona afectada por escrito y que se garantice el anonimato de la información.
- D. Basta con que la actuación se encuentre debidamente autorizada.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Art. 9 Creación de los sistemas de información necesarios para facilitar el ejercicio adecuado de los distintos niveles de responsabilidad en el sistema. A tal fin, los datos de carácter personal relativos a la salud podrán ser recabados y tratados para el ejercicio de las funciones de dirección, planificación y programación del sistema, requiriéndose, siempre que no conste el previo consentimiento del afectado, que la actuación se encuentre debidamente autorizada y se efectúe previo procedimiento de disociación que garantice el anonimato en la información.

PREGUNTA 41

LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI AL CONTEMPLAR LOS DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS, ALUDE A:

- A. La obligación de dejar constancia escrita de todo proceso diagnóstico o terapéutico.
- B. La obligación de dejar constancia por cualquier medio de todo proceso diagnóstico.
- C. La obligación de dejar constancia por cualquier medio de todo proceso diagnóstico o terapéutico.
- D. No existe en la Ley ninguna previsión a este respecto, de modo que será el personal facultativo el que decida si el proceso diagnóstico o terapéutico debe quedar registrado.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Artículo 10. Derechos y deberes de carácter instrumental y complementario. 1. El sistema sanitario de Euskadi garantizará el desarrollo y aplicación de todos los derechos y deberes de carácter instrumental y complementario que deriven de la regulación legal del derecho a la protección de la salud, potenciando, entre otros, el máximo respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad de las personas en sus relaciones con los servicios sanitarios, así como la observancia de la obligación de dejar constancia escrita de todo proceso diagnóstico o terapéutico, y de recabar el consentimiento correspondiente, previas las condiciones necesarias de información.

PREGUNTA 42

EL CONTRATO-PROGRAMA, TAL Y COMO ESTABLECE LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI:

- A. Es el instrumento jurídico mediante el que se articulan las relaciones entre el Gobierno Vasco y las organizaciones del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud para la provisión de servicios sanitarios.
- B. Es el instrumento jurídico mediante el que se articulan de manera directa las relaciones entre el Departamento competente en materia de sanidad y las organizaciones del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud que tiene naturaleza jurídica de concierto.
- C. Es el instrumento jurídico mediante el que se articulan de manera directa las relaciones entre el Departamento competente en materia de sanidad y las organizaciones del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud que tiene naturaleza jurídica de un convenio de carácter especial.
- D. Ninguna respuesta es correcta.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Artículo 19. El contrato-programa.

- 1. A los efectos de esta ley, el contrato-programa constituye el instrumento jurídico mediante el

cual se articulan de manera directa las relaciones entre el Departamento competente en materia de sanidad y las organizaciones del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud para la provisión de servicios sanitarios.

- 2. El contrato-programa tendrá la naturaleza jurídica de un convenio de carácter especial.

PREGUNTA 43

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD ESTÁ INTEGRADO POR:

- A. La persona titular de la presidencia y por un número no superior a cinco miembros en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- B. La persona titular de la presidencia y por un número no superior a tres miembros en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- C. La persona titular de la presidencia y por cinco miembros en representación del Departamento competente en materia de sanidad.
- D. La persona titular de la presidencia, la Consejería del Departamento competente en materia de sanidad y tres miembros en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Art 22. El consejo de administración estará integrado por el presidente y por un número no superior a cinco miembros en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

PREGUNTA 44

SEGÚN ESTABLECE LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI:

- A. El Plan de Salud de Euskadi debe ser aprobado por el Parlamento Vasco.
- B. El Departamento competente en materia de sanidad debe elaborar semestralmente y remitir al Parlamento un informe con la evaluación

de los objetivos y determinaciones del Plan de Salud de Euskadi.

- C. El Departamento competente en materia de sanidad debe elaborar anualmente y remitir al Parlamento un informe con la evaluación de los objetivos y determinaciones del Plan de Salud de Euskadi.
- D. Son correctas las respuestas a) y c).

Respuesta correcta: C

Comentario:

Artículo 13. Plan de Salud de Euskadi.

- 2. Corresponderá su aprobación al Gobierno Vasco, a propuesta del órgano superior responsable en materia de sanidad, y deberá ser elevado al Parlamento Vasco para su tramitación reglamentaria como comunicación.
- 3. Corresponde al Departamento competente en materia de sanidad elaborar anualmente y remitir al Parlamento un informe con la evaluación de los objetivos y determinaciones del Plan de Salud de Euskadi.

PREGUNTA 45

A LOS EFECTOS DE LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI, LAS PLANTILLAS DE PERSONAL DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD:

- A. Serán aprobadas por la Presidencia a propuesta del consejo de administración.
- B. Se denomina así al número de efectivos de carácter estructural con que cuentan tanto su organización central de administración como las organizaciones de servicios dependientes de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
- C. Deberán ajustarse al número máximo de efectivos, según grupos profesionales, que anualmente aprobará su consejo de administración a propuesta del Departamento de Sanidad.
- D. Deberán ajustarse al número máximo de efectivos, según grupos de titulación, que anualmente aprobará el Departamento de Sanidad.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Art 26, las plantillas de personal del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, que serán aprobadas por su consejo de administración, constituyen el número de efectivos de carácter estructural con que cuentan tanto su organización central de administración como las organizaciones de servicios sanitarios dependientes del mismo. Dichas plantillas deberán ajustarse al número máximo de efectivos, según grupos profesionales, que anualmente aprobará el Consejo de Gobierno a propuesta del Departamento de Sanidad.

PREGUNTA 46

EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, LAS INSPECCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI Y EN EL RESTO DE LA LEGISLACIÓN SANITARIA CORRESPONDE:

- A. A la inspección de trabajo del País Vasco adscrita al Departamento de trabajo y empleo del Gobierno Vasco.
- B. En todos los casos a las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma.
- C. Al Departamento competente en materia de sanidad.
- D. La inspección en materia sanitaria no es competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Artículo 33. Inspección.

- 1. Corresponde al Departamento competente en materia de sanidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi la realización en su ámbito territorial de las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo previsto en esta ley y en el resto de la legislación sanitaria.

PREGUNTA 47

SEÑALE CUÁL DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS NO ESTÁ CONTEMPLADO EN LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES EN LEVES, GRAVES O MUY GRAVES:

- A. La cuantía de la indemnización solicitada.
- B. Los riesgos para la salud.
- C. El grado de intencionalidad.
- D. La gravedad de la alteración sanitaria y social producida.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Artículo 36. Infracciones. 1. Las infracciones se califican como leves, graves o muy graves, atendiendo a los criterios de riesgos para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y reincidencia.

PREGUNTA 48

SEGÚN ESTABLECE LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI, EN MATERIA DE SANCIONES SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:

- A. Las infracciones serán sancionadas exclusivamente con sanción pecuniaria o económica.
- B. En los casos de infracciones muy graves, el Gobierno Vasco podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años.
- C. Sin perjuicio de la multa que proceda imponer, en ciertos casos, la sanción económica que se imponga podrá ser incrementada hasta el triple de la cuantía del beneficio ilícito obtenido.
- D. En los casos de infracciones muy graves, el Gobierno Vasco podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de tres años.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Art. 37.

- 3. Sin perjuicio de la multa que proceda imponer conforme al anterior apartado, a fin de impedir que la comisión de infracciones resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas, la sanción económica que en su caso se imponga podrá ser incrementada con la cuantía del beneficio ilícito obtenido.
- 4. En los supuestos de infracciones muy graves, podrá acordarse por el Gobierno Vasco el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años, con los efectos laborales que determine la legislación correspondiente.”

PREGUNTA 49

SEGÚN LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI, LAS ORGANIZACIONES A TRAVÉS DE LAS QUE SE PROCEDE A LA PROVISIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CON MEDIOS ADSCRITOS AL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD:

- A. Realizarán su actividad bajo el principio de autonomía económico-financiera y de gestión.
- B. Se configurarán como instituciones de titularidad privada y con personalidad jurídica propia.
- C. Se crearán por ley como entidades de titularidad pública y con personalidad jurídica propia.
- D. Para realizar su actividad dependen presupuestariamente del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Artículo 23. Régimen de gestión.

- 1. La provisión de servicios sanitarios con medios adscritos al ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se realizará a través de organizaciones que realizarán su actividad bajo el principio de autonomía económico-financiera y de gestión.
- 2. Dichas organizaciones se podrán configurar como instituciones sanitarias del ente sin personalidad jurídica propia, o bien como entidades sanitarias dependientes del mismo, de titularidad pública y con personalidad jurídica

ca propia. En este caso, las mismas podrán adoptar cualquiera de las figuras organizativas previstas en el ordenamiento jurídico y su creación se realizará mediante decreto del Gobierno.

3. En todo caso, la autonomía de gestión llevará aparejado el reconocimiento a las organizaciones de servicios sanitarios del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud de capacidad para suscribir un contrato-programa con el órgano competente de la Administración General, en los términos que señala esta ley. Asimismo dichas organizaciones tendrán aprobados, en el marco consolidado del ente público, su presupuesto individualizado y sus planes de gestión a corto y medio plazo.

PREGUNTA 50

RESPECTO AL PERSONAL SUJETO AL RÉGIMEN ESTATUTARIO QUE ESTABLECE LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI, SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:

- A. Este vínculo estatutario se adquiere mediante el cumplimiento de los dos siguientes requisitos: superación del proceso selectivo correspondiente y nombramiento conferido por autoridad competente.
- B. Los principios que rigen el procedimiento selectivo para la adquisición del vínculo estatutario son exclusivamente el de igualdad, mérito y capacidad.
- C. Los instrumentos de clasificación del personal sujeto a este régimen estatutario son el grupo de titulación, el grupo profesional, la categoría y el puesto funcional que se desempeñe.
- D. El grupo de titulación constituye el instrumento de clasificación del personal en base al agrupamiento unitario de las aptitudes profesionales y contenido específico de las tareas propias de la prestación.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Art. 28.

2. El presente vínculo estatutario se adquiere mediante el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:
 - a. Superación del procedimiento selectivo correspondiente.
 - b. Nombramiento conferido por autoridad competente.
 - c. Toma de posesión dentro del plazo reglamentario.
3. El procedimiento selectivo para adquisición del vínculo estatutario se ajustará a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad:
 1. Constituyen instrumentos de clasificación del personal sujeto al presente régimen jurídico el grupo de titulación, el grupo profesional, la categoría y el puesto funcional que se desempeñe.
 2. El grupo de titulación constituye el instrumento de clasificación del personal en base al nivel de titulación exigido para su ingreso. En cada grupo de titulación se agruparán los grupos profesionales que correspondan.”

PREGUNTA 51

CORRESPONDERÁ LA PRESIDENCIA DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD A:

- A. Quien ostente la presidencia del Gobierno (Lehendakari) de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- B. La Diputación General del Territorio Histórico en que esté situado el Ente.
- C. La presidencia a quien ostente la titularidad del Departamento de Sanidad y la presidencia de honor a quien ostente la presidencia del Gobierno (Lehendakari) de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- D. Quien ostente la titularidad de del Departamento de Sanidad.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Artículo 22. Organización rectora. 1. Los órganos rectores del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud son el consejo de administración y el presidente, cuyo cargo ejercerá el Consejero del Departamento competente en materia de sanidad.

PREGUNTA 52

LA FUNCIÓN DE NOMBRAR Y SEPARAR A QUIENES OCUPEN LAS DIRECCIONES DE DIVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CENTRAL DEL ENTE PÚBLICO CORRESPONDE A:

- A. El Consejo de Administración del Ente.
- B. La Dirección General del Ente.
- C. La Presidencia del Ente.
- D. Ninguno de los anteriores.

Respuesta correcta: A

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud: Corresponderán al Consejo de Administración de Osakidetza: Nombrar y separar al Director General y, a propuesta de este último, a los Directores de División de la organización central del Ente Público.

PREGUNTA 53

LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD CONTARÁ, ADEMÁS DE LA PERSONA QUE EJERZA LA PRESIDENCIA:

- A. Con cinco integrantes en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma, que nombrará el Gobierno: una persona a propuesta de la titularidad del Departamento de Hacienda y Administración Pública, otra a propuesta de quien ostente la titularidad de Bienestar Social y las tres restantes a propuesta de la persona titular de Sanidad.
- B. Con cinco integrantes en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma, que nombrará el Gobierno: una persona a propuesta de la titularidad del Departamento de

Hacienda y Administración Pública, otra a propuesta de la persona titular de la Consejería de Presidencia y las tres restantes a propuesta de la persona titular de Sanidad.

- C. Con cinco integrantes en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma, que nombrará el Gobierno: dos a propuesta de la persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública y las tres restantes a propuesta de la persona titular de Sanidad.
- D. Ninguna de los anteriores.

Respuesta correcta: C

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud: La composición del Consejo contará, además del Presidente del Ente Público, con cinco miembros en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma, que serán nombrados por el Gobierno, dos de ellos a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y los tres restantes a propuesta del Consejero de Sanidad.

PREGUNTA 54

LA PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD:

- A. Será formulada por la Dirección General del Ente.
- B. Será aprobada por la Presidencia del Ente.
- C. Será sometida a informe del Consejo de Administración del Ente.
- D. Todas las anteriores son ciertas.

Respuesta correcta: A

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud: Corresponde al Consejo de Administración de Osakidetza: Aprobar, a propuesta del Director General, el Plan Estratégico del Ente Público.

PREGUNTA 55

LA FUNCIÓN DE CONVOCAR, PRESIDIR, SUSPENDER Y LEVANTAR LAS SESIONES, ARBITRAR LAS DELIBERACIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA- SERVICIO VASCO DE SALUD Y DECIDIR LOS EMPATES CON SU VOTO DE CALIDAD CORRESPONDERÁ A:

- A. La Dirección General.
- B. La Presidencia.
- C. La persona de mayor antigüedad del Consejo de Administración.
- D. Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud: Corresponderá al Presidente del Ente Público convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones, arbitrar las deliberaciones del Consejo de Administración y decidir los empates con su voto de calidad, así como autorizar la asistencia de otras personas a las reuniones del Consejo si su presencia se juzga conveniente por la naturaleza de los asuntos a tratar.

PREGUNTA 56

LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA- SERVICIO VASCO DE SALUD:

- A. No podrá asistir a las reuniones del Consejo de Administración del Ente.
- B. Presidirá las reuniones del Consejo de Administración del Ente.
- C. Asistirá a las reuniones del Consejo de Administración del Ente con voz y voto.
- D. Asistirá a las reuniones del Consejo de Administración del Ente con voz y sin voto.

Respuesta correcta: D

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud: Corres-

ponde al Director General: Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración y elevar al mismo las propuestas que le correspondan, así como los informes, estudios y análisis que le sean requeridos. A tal efecto, asistirá a las reuniones del Consejo de Administración con voz y sin voto.

PREGUNTA 57

CORRESPONDE A LA ORGANIZACIÓN CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, EN MATERIA DE GESTIÓN ASISTENCIAL (SEÑÁLESE LA RESPUESTA INCORRECTA):

- A. Supervisar el cumplimiento de las políticas generales de calidad y realizar auditorías.
- B. Definir criterios generales y proponer la política de precios correspondiente a la prestación de servicios sanitarios incluida en la cobertura pública.
- C. Coordinar los recursos y, en su caso, proponer medidas de intervención sobre las listas de espera.
- D. Promover protocolos de interés general.

Respuesta correcta: B

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud: En materia específica de gestión asistencial:

- Supervisar el cumplimiento de las políticas generales de calidad y realizar auditorías.
- Autorizar la incorporación de nuevos dispositivos tecnológicos.
- Coordinar los recursos y, en su caso, proponer medidas de intervención sobre las listas de espera.
- Promover protocolos de interés general.
- Definir criterios generales y proponer la política de precios correspondiente a la prestación de servicios sanitarios no incluida en la cobertura pública.

PREGUNTA 58

CORRESPONDE A LA ORGANIZACIÓN CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SEÑÁLESE LA RESPUESTA INCORRECTA):

- A. Supervisar, controlar y evaluar las políticas de personal del Ente.
- B. Promover acuerdos de cooperación con centros correspondientes a la sanidad privada.
- C. Dirigir el funcionamiento del registro de personal.
- D. Gestionar los procesos de selección y de provisión que el Consejo de Administración determine, por su carácter general, previsible número de aspirantes u otras circunstancias análogas, y, a tal fin, convocarlos, establecer sus bases, programas y contenidos, y designar a los tribunales calificadores de los mismos.

Respuesta correcta: B

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud: En materia específica de gestión de recursos humanos:

- Supervisar, controlar y evaluar las políticas de personal del Ente.
- Proponer los criterios de clasificación de los Puestos Funcionales.
- Dirigir el funcionamiento del registro de personal.
- Gestionar los procesos de selección y de provisión que el Consejo de Administración determine, por su carácter general, previsible número de aspirantes u otras circunstancias análogas, y, a tal fin, convocarlos, establecer sus bases, programas y contenidos, y designar a los tribunales calificadores de los mismos.
- Gestionar la reasignación de efectivos de carácter general y planificado, elaborando, en su caso, Planes de Empleo referidos al personal adscrito a todas o a parte de las organizaciones del Ente Público.
- Representar al Ente Público en la negociación colectiva del Acuerdo Marco de Condiciones de Trabajo del Personal.
- Impulsar y coordinar la ejecución del Plan de Normalización Lingüística.

PREGUNTA 59

CORRESPONDE A CADA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD EL

EJERCICIO DE TODAS LAS FACULTADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE SE REQUIERAN PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS QUE TENGAN ENCOMENDADA, QUEDANDO EXCLUIDAS ÚNICAMENTE:

- A. Aquellas facultades de gestión centralizada que los estatutos sociales del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud atribuyen expresamente a la organización central del Ente Público y las competencias propias de otras instancias de acuerdo con las Leyes y Reglamentos vigentes.
- B. Aquellas facultades de gestión centralizada que los estatutos sociales del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud atribuyen expresamente a la Presidencia del Ente Público y las competencias propias de otras instancias de acuerdo con las Leyes y Reglamentos vigentes.
- C. Aquellas facultades de gestión centralizada que los estatutos sociales del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud atribuyen expresamente al Consejo de Administración del Ente Público y las competencias propias de otras instancias de acuerdo con las Leyes y Reglamentos vigentes.
- D. Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: A

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud. Artículo 14 — Facultades de las organizaciones de servicios. — Corresponde a cada organización de servicios del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud el ejercicio de todas las facultades de gestión y administración que se requieran para el ejercicio de la actividad de provisión de servicios sanitarios que tengan encomendada, quedando excluidas únicamente aquellas facultades de gestión centralizada que los presentes Estatutos atribuyen expresamente a la organización central del Ente Público, así como las competencias propias de otras instancias de acuerdo con las Leyes y Reglamentos vigentes.

PREGUNTA 60

EL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD:

- A. Oscilará entre dos y tres.
- B. Oscilará entre tres y cuatro.
- C. Oscilará entre cuatro y cinco.
- D. La normativa que rige su estatuto jurídico no establece un número determinado sino un máximo de cinco.

Respuesta correcta: D

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud.: Para el desarrollo de sus funciones el Director-Gerente podrá contar con el apoyo de un equipo directivo, cuyos miembros estarán sujetos al régimen previsto en el artículo 27 de la Ley de Ordenación sanitaria de Euskadi, delimitándose su número en función de las necesidades que deriven de la complejidad y volumen de actividad, la estrategia de eficiencia en la organización y las plantillas correspondientes. Además del Director-Gerente, las organizaciones de servicios sanitarios del Ente Público podrán contar con un máximo de hasta cinco cargos directivos.

PREGUNTA 61

LA FUNCIÓN DE REPRESENTAR AL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DEL ACUERDO MARCO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL CORRESPONDE A:

- A. La organización central de administración y gestión corporativa del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
- B. La Presidencia del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
- C. El Consejo de Administración del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
- D. Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: A

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud: Corresponde a la organización central de administración y gestión corporativa del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud.: Representar al Ente Público en la negociación colectiva del Acuerdo Marco de Condiciones de Trabajo del Personal.

PREGUNTA 62

PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DE PROPUESTA Y ASESORAMIENTO, ASÍ COMO DE PARTICIPACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS, EXISTIRÁ UN CONSEJO DE DIRECCIÓN EN CADA UNA DE ELLAS, INTEGRADO POR:

- A. El equipo directivo, las jefaturas de unidad que se determinen y una representación de personas vocales electas que formen parte de los Consejos Técnicos de participación profesional respectivos.
- B. El equipo directivo, las jefaturas de unidad que se determinen, representantes sindicales y una representación de personas vocales electas que formen parte de los Consejos Técnicos de participación profesional respectivos.
- C. El equipo directivo y las jefaturas de unidad que se determinen.
- D. Todas las anteriores son falsas.

Respuesta correcta: A

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud: Para el desarrollo de funciones de propuesta y asesoramiento, así como de participación en las organizaciones de servicios, existirá un Consejo de Dirección en cada organización, integrado por el equipo directivo, las jefaturas de unidad que se determinen y una representación de los vocales electos que formen parte de los Consejos Técnicos de participación profesional respectivos.

PREGUNTA 63

LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD PODRÁN:

- A. Descentralizar la organización y su funcionamiento operativo, delegando en quienes ostenten la responsabilidad clínica facultades de gestión, aunque solo en materia de personal y siempre de acuerdo con el marco estratégico, los planes de gestión y el compromiso del contrato-programa suscrito por la organización.
- B. Descentralizar la organización y su funcionamiento operativo, delegando en quienes ostenten la responsabilidad clínica facultades de gestión, pero solo en materia económica y siempre de acuerdo con el marco estratégico, los planes de gestión y el compromiso del contrato-programa suscrito por la organización.
- C. Descentralizar la organización y su funcionamiento operativo, delegando en quienes ostenten la responsabilidad clínica facultades de gestión tanto en materia económica como de personal, de acuerdo con el marco estratégico, los planes de gestión y el compromiso del contrato-programa suscrito por la organización.
- D. Todas las anteriores son falsas.

Respuesta correcta: C

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud: Podrán descentralizar la organización y su funcionamiento operativo, delegando en los responsables clínicos facultades de gestión tanto en materia económica como de personal, de acuerdo con el marco estratégico, los planes de gestión y el compromiso del contrato-programa suscrito por la organización.

PREGUNTA 64

EN MATERIA ESPECÍFICA DE INVERSIONES, LA COMPETENCIA PARA EJECUTAR LAS COMPRAS DE SUMINISTROS QUE SE CONSIDEREN CENTRALIZADAS, ASÍ COMO DEFINIR Y/O EJECUTAR, EN SU CASO, LAS CONSIDERADAS INTEGRADAS CORRESPONDE A:

- A. El Consejo de Administración del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
- B. La organización central de administración y gestión corporativa del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
- C. La organización de servicios del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
- D. A quien ostente la titularidad de la Dirección-Gerencia de cada organización de servicios sanitarios del Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Respuesta correcta: B

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud: Corresponde a la organización central de administración y gestión corporativa del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud: En materia específica de inversiones: Ejecutar las compras de suministros que se consideren centralizadas, así como definir y/o ejecutar, en su caso, las consideradas integradas.

PREGUNTA 65

EN EL ÁMBITO DE UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, PRESIDIR LOS CONSEJOS TÉCNICOS DE PARTICIPACIÓN PROFESIONAL Y PROMOVER SU EFICAZ FUNCIONAMIENTO ES UNA TAREA QUE CORRESPONDE A:

- A. La Dirección General del Ente.
- B. Quien ostente la titularidad de la Dirección-Gerencia del Ente.
- C. La Dirección Médica del Ente.
- D. Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Comentario:

DECRETO 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud: Con carácter ordinario, a la Dirección Médica le corresponderán las siguientes atribuciones: Presidir los Consejos Técnicos de participación profesional y promover su eficaz funcionamiento.

PREGUNTA 66

SEGÚN EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, ¿QUÉ DOS NIVELES ASISTENCIALES SE INTEGRAN EN LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS (OSI) DE OSAKIDETZA?

- A. Atención especializada y Atención de Urgencias.
- B. Salud Pública y Servicios Sociosanitarios.
- C. Atención hospitalaria y Atención de Emergencias.
- D. Atención primaria y Atención hospitalaria.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Constituye el objeto del presente Decreto la regulación de las organizaciones sanitarias integradas, también denominadas OSI, del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud como estructuras orgánicas unificadas en las que se integran la atención primaria y la atención hospitalaria, que actuarán bajo el principio de autonomía económico-financiera y de gestión.

PREGUNTA 67

SEGÚN EL ARTÍCULO 2.1 DEL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, ¿QUÉ OBJETIVO ÚLTIMO PERSIGUE LA CONFIGURACIÓN DE LAS OSI?

- A. Reducir el gasto farmacéutico mediante la unificación de compras.
- B. Favorecer la integración clínica de manera que la atención se articule en torno a la persona.
- C. Centralizar los servicios de atención primaria en las sedes hospitalarias.
- D. Eliminar las categorías profesionales de atención primaria para unificarlas con las hospitalarias.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Las OSI se configuran como organizaciones de servicios sanitarios dependientes del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud para realizar la

actividad de provisión de servicios sanitarios aglutinando dispositivos y procesos asistenciales de atención primaria con los de atención hospitalaria con el objetivo último de favorecer la integración clínica en el proceso asistencial del y de la paciente de manera que la atención sanitaria se articule en torno a la persona que constituye el centro de la actividad asistencial.

PREGUNTA 68

SEGÚN EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, ¿BAJO QUÉ PRINCIPIO FUNDAMENTAL ACTUARÁN LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS (OSI) DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD?

- A. Principio de coordinación territorial y sectorial.
- B. Principio de jerarquía funcional única.
- C. Principio de autonomía económico-financiera y de gestión.
- D. Principio de centralización de todos los recursos.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Constituye el objeto del presente Decreto la regulación de las organizaciones sanitarias integradas, también denominadas OSI, del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud como estructuras orgánicas unificadas en las que se integran la atención primaria y la atención hospitalaria, que actuarán bajo el principio de autonomía económico-financiera y de gestión.

PREGUNTA 69

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, ¿CÓMO SE DEFINE UNA OSI DE CLASE “MONOGRÁFICA”?

- A. Es aquella donde solo se integran servicios de atención hospitalaria especializada.
- B. Es aquella cuya actividad asistencial gira en torno a un ámbito específico, integrando sus servicios y dispositivos.

- C. Es una organización que solo atiende a una patología crónica específica.
- D. Es la organización que carece de servicios de atención primaria.

Respuesta correcta: B

Comentario:

OSI monográfica, en la que la actividad asistencial gira con carácter general en torno a un ámbito específico.

PREGUNTA 70

SEGÚN EL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, LAS OSI DE TIPO I SE CARACTERIZAN, ENTRE OTROS ASPECTOS, POR TENER HOSPITALES DE CARÁCTER UNIVERSITARIO Y, ADEMÁS, POR DISPONER DE:

- A. Una base poblacional adscrita inferior a 300.000 habitantes.
- B. Una Dirección de Gestión que asume todas las funciones asistenciales.
- C. Unidades o servicios calificados de referencia para el conjunto del sistema sanitario vasco.
- D. Ser organizaciones de servicios de carácter monográfico y de pequeño tamaño.

Respuesta correcta: C

Comentario:

OSI de tipo I. Constituirán OSI de tipo I aquellas organizaciones con hospitales de carácter universitario, alta complejidad y que dispongan de unidades o servicios calificados de referencia para el conjunto del sistema sanitario vasco establecida por Acuerdo del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

PREGUNTA 71

SEGÚN EL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, PARA QUE UNA OSI SEA CLASIFICADA

COMO DE TIPO III DEBE INTEGRAR, JUNTO CON SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA, UN HOSPITAL DE CARÁCTER GENERAL Y TENER UNA BASE POBLACIONAL ATENDIDA INFERIOR A:

- A. 500.000 habitantes.
- B. 200.000 habitantes.
- C. 300.000 habitantes.
- D. 100.000 habitantes.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Constituirán OSI de tipo III aquellas organizaciones de servicios que, junto con servicios y unidades de atención primaria, integran un hospital de carácter general y tengan una base poblacional atendida inferior a 300.000 habitantes.

PREGUNTA 72

SEGÚN EL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, ¿CUÁLES SON LOS TRES ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS OSI?

- A. El Consejo de Dirección, el Comité Ejecutivo y el Comité de Ética Asistencial.
- B. El Consejo Clínico Asistencial, el Consejo Social y la Comisión Sociosanitaria.
- C. La Comisión de Seguridad, la Comisión de Docencia y la Comisión de Investigación.
- D. El Consejo de Dirección, el Consejo Social y el Comité de Evaluación.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Los órganos de participación de las OSI son el Consejo Clínico Asistencial, el Consejo Social y la Comisión Sociosanitaria.

PREGUNTA 73

DE ACUERDO CON EL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VAS-

CO DE SALUD, ¿QUÉ ÓRGANOS COMPONEN EL EQUIPO DIRECTIVO DE UNA OSI, SEGÚN LA ESTRUCTURA GENERAL DEL ARTÍCULO 5.2?

- A. Solo la Dirección Gerencia y la Dirección Médica.
- B. Las Direcciones Médica, de Atención Integrada, de Enfermería, de Personas, Económico-Financiera y de Gestión.
- C. El Consejo de Dirección y el Consejo Social exclusivamente.
- D. La Dirección Gerencia y las Jefaturas de Servicio de cada centro de salud.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Los órganos de dirección de las OSI son: la dirección gerencia, el equipo directivo, (conformado por la dirección médica, la dirección de atención integrada, la dirección de enfermería, la dirección de personal, la dirección económico financiera y la dirección de gestión) y el consejo de dirección.

PREGUNTA 74

DE ACUERDO CON EL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, EN LAS OSI DE TIPO IV, LA DIRECCIÓN GERENCIA ASUME, CON EL APOYO DE PUESTOS FUNCIONALES ASISTENCIALES, LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN A:

- A. La Dirección de Personas y la Dirección Económico-Financiera.
- B. La Dirección de Personas y la Dirección de Atención Integrada.
- C. La Dirección Médica y la Dirección de Enfermería.
- D. La Dirección de Gestión y el Consejo de Dirección.

Respuesta correcta: C

Comentario:

La Dirección Gerencia, por su parte, asumirá las funciones que corresponden a la Dirección Médica y a la Dirección de Enfermería, con el apoyo y delegación, en su caso, de los puestos funcionales asistenciales que determine.

PREGUNTA 75

DE ACUERDO CON EL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN ENCARGADO DEL GOBIERNO Y GESTIÓN DE LAS OSI DE TIPO I Y II?

- A. La Dirección de Personas.
- B. El Consejo Clínico Asistencial.
- C. La Dirección de Atención Integrada.
- D. La Dirección Económico-Financiera.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Las OSI de tipo I y II dispondrán de los siguientes órganos de dirección, encargados de su gobierno y gestión:

- La Dirección Gerencia.
- La Dirección Médica.
- La Dirección de Atención Integrada.
- La Dirección de Enfermería.
- La Dirección de Personas.
- La Dirección Económico-Financiera.
- El Consejo de Dirección.

PREGUNTA 76

SEGÚN EL ARTÍCULO 7.3 DEL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, ¿QUIÉN TIENE LA COMPETENCIA PARA EL NOMBRAMIENTO Y CESE DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GERENCIA?

- A. El Consejero o la Consejera de Salud.
- B. La Dirección General del Ente Público Osakidetza.
- C. El Consejo de Administración a propuesta de Lehendakaritza.
- D. La Dirección de Personas de la propia OSI.

Respuesta correcta: B

Comentario:

El nombramiento y cese de la persona en el cargo directivo de la Dirección Gerencia se efectuará por la Dirección General del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud.

PREGUNTA 77

SEGÚN LOS ARTÍCULOS 7 Y 9 DEL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, ¿CUÁL ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS CARGOS DE DIRECCIÓN DE UNA OSI?

- A. Haber pertenecido al Consejo Clínico Asistencial durante al menos dos años.
- B. Superar un examen de oposición específico para gerencia sanitaria.
- C. Previa convocatoria pública donde se acredite titulación, capacidad y experiencia profesional.
- D. Tener la condición de personal estatutario fijo en la categoría de técnico/a superior.

Respuesta correcta: C

Comentario:

El nombramiento requerirá previa convocatoria pública en la que se acrediten los requisitos necesarios de titulación universitaria, capacidad y experiencia profesional para el desempeño del cargo.

PREGUNTA 78

SEGÚN EL ARTÍCULO 8.M DEL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, ¿A QUÉ DIRECCIÓN CORRESPONDE “ORIENTAR LA GESTIÓN DESDE UNA VISIÓN INTEGRADORA EMPODERANDO LA ATENCIÓN PRIMARIA”?

- A. Dirección de Atención Integrada.
- B. Dirección Gerencia.
- C. Dirección de Enfermería.
- D. Dirección Económico-Financiera.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Corresponden a la Dirección Gerencia las siguientes funciones: Orientar la gestión desde una visión integradora empoderando la atención primaria y proporcionando un desarrollo armónico de los diferentes niveles asistenciales de la organización.

PREGUNTA 79

DE ACUERDO CON EL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, ¿CON QUÉ ÁMBITO(S) ADICIONAL(ES) DEBE COORDINAR SU ACTIVIDAD LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRADA, ADEMÁS DE CON LA ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALARIA?

- A. Con el ámbito de Recursos Humanos y con la Universidad.
- B. Con el ámbito comunitario y socio-sanitario.
- C. Únicamente con el sociosanitario.
- D. Con las entidades locales y las empresas privadas de gestión.

Respuesta correcta: B

Comentario:

La Dirección de Atención Integrada es el órgano encargado de la integración de la actividad asistencial ambulatoria de los niveles de atención primaria y hospitalaria de la OSI, en coordinación con la Dirección Médica y la Dirección de Enfermería. Asimismo, la Dirección de Atención Integrada es el órgano encargado de la coordinación de su actividad con la de otros ámbitos como son el comunitario y socio-sanitario, con la finalidad de impulsar el vínculo con la comunidad a través de la promoción y prevención de la salud y la atención socio-sanitaria.

PREGUNTA 80

SEGÚN EL ARTÍCULO 19.1 DEL DECRETO 100/2018 DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, ¿QUIÉN EJERCE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO CLÍNICO ASISTENCIAL?

- A. La persona titular de la Dirección Gerencia.
- B. La persona titular de la Dirección Médica.
- C. La persona titular de la Dirección de Enfermería.
- D. La persona de mayor antigüedad en la vocalía de Atención Primaria.

Respuesta correcta: B

Comentario:

La Dirección Médica, que actuará como presidente o presidenta del Consejo.

PREGUNTA 81

SEGÚN EL DECRETO 147/2015, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA DECLARACIÓN SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI, SON TITULARES DE LOS DERECHOS Y DEBERES RECOGIDOS EN ESTA DECLARACIÓN:

- A. Todas las personas que accedan o utilicen las prestaciones y servicios sanitarios que se proporcionan por el sistema sanitario de Euskadi.
- B. Todas las personas nacidas en Euskadi.
- C. Todas las personas empadronadas en Euskadi.
- D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Son titulares de los derechos y deberes recogidos en esta Declaración todas las personas que accedan o utilicen las prestaciones y servicios sanitarios que se proporcionan por el sistema sanitario de Euskadi.

PREGUNTA 82

SEGÚN EL DECRETO 147/2015, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA DECLARACIÓN SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI, TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS SON EXIGIBLES:

- A. En relación a todas las acciones de carácter sanitario, incluyendo docencia, que se desarrollen en los centros, servicios o establecimientos sanitarios de titularidad pública o privada o concertados de Euskadi. Las acciones relativas a la investigación biomédica quedan fuera de esta Declaración y se rigen por su normativa específica.
- B. En relación a todas las acciones de carácter sanitario, incluyendo docencia, que se desarrollen en los centros, servicios o establecimientos sanitarios de titularidad pública o concertados que integran el sistema sanitario de Euskadi. Las acciones relativas a la investigación biomédica quedan fuera de esta Declaración y se rigen por su normativa específica.
- C. En relación a todas las acciones de carácter sanitario, incluyendo investigación y docencia,

que se desarrollen en los centros, servicios o establecimientos sanitarios de titularidad pública o privada o concertados de Euskadi.

- D. En relación a todas las acciones de carácter sanitario, incluyendo investigación y docencia, que se desarrollen en los centros, servicios o establecimientos sanitarios de titularidad pública o concertados que integran el sistema sanitario de Euskadi.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Los derechos y obligaciones establecidos son exigibles en relación a todas las acciones de carácter sanitario, sean de promoción, prevención, asistencial o de investigación y docencia que se desarrollen en los centros, servicios o establecimientos sanitarios de titularidad pública o concertados que integran el sistema sanitario de Euskadi.

PREGUNTA 83

SEGÚN EL DECRETO 147/2015, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA DECLARACIÓN SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI, LOS PRINCIPIOS QUE INFORMAN E INSPIRAN EL CONJUNTO DE ACCIONES DE CARÁCTER SANITARIO QUE SE DESARROLLEN EN EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI SON:

- A. El respeto a la libertad de la persona, a su dignidad y a la autonomía en las decisiones que afecten a su salud.
- B. El respeto a todo el personal profesional que integra el sistema sanitario de Euskadi.
- C. La promoción de la investigación científica en el marco del sistema sanitario de Euskadi.
- D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Los principios que informan e inspiran el conjunto de acciones de carácter sanitario que se desarrollen en el sistema sanitario de Euskadi son:

- a. El respeto a la libertad de la persona, a su dignidad y a la autonomía en las decisiones que afecten a su salud.

- b. El respeto a la vida y a la integridad física y psíquica.
- c. La igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, edad, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad o enfermedad, religión, moral, opinión, ideología, situación económica, idioma, o por cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.
- d. La universalidad de la asistencia sanitaria y el acceso a los servicios asistenciales disponibles en condiciones de igualdad efectiva.
- e. La solidaridad y la equidad en el acceso, en el uso y la calidad de los servicios sanitarios.
- f. La confianza entre las y los agentes intervinientes en la relación asistencial y la confidencialidad de los datos sobre la salud y de la información que se genera en las relaciones clínicas.
- g. El respeto al libre desarrollo de la personalidad y de los diferentes proyectos de vida.
- h. La responsabilidad y la participación de las personas en la gestión de su salud.

PREGUNTA 84

A LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI RECOGIDA EN EL DECRETO 147/2015, DE 21 DE JULIO, SE CONFIGURAN LAS SIGUIENTES FASES DE LA VIDA EN LAS QUE SE CONCRETAN NECESIDADES ESPECÍFICAS:

- A. 1. Neonatología, infancia y adolescencia. 2. Salud sexual y reproductiva, embarazo y parto. 3. Salud laboral. 4. Personas mayores y final de la vida.
- B. 1. Infancia y adolescencia. 2. Salud sexual y reproductiva. 3. Salud laboral. 4. Personas mayores.
- C. 1. Infancia. 2. Adolescencia, salud sexual y reproductiva. 3. Personas mayores. 4. Final de la vida.
- D. 1. Infancia y adolescencia. 2. Salud sexual y reproductiva. 3. Personas mayores. 4. Final de la vida.

Respuesta correcta: D**Comentario:**

A los efectos de esta Declaración se configuran las siguientes fases de la vida en las que se concretan necesidades específicas:

- 1. Necesidades específicas de la infancia y la adolescencia.
- 2. Necesidades específicas en la salud sexual y reproductiva.

- 3. Necesidades específicas de las personas mayores.
- 4. Necesidades específicas del final de la vida.

PREGUNTA 85

SEGÚN EL DECRETO 147/2015, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA DECLARACIÓN SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI, LAS PERSONAS PACIENTES Y USUARIAS DEL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI, EN RELACIÓN CON LA ASISTENCIA SANITARIA ESPECÍFICA REFERIDA AL FINAL DE LA VIDA, TIENEN DERECHO A:

- A. Al acompañamiento de familiares y personas allegadas en los procesos con hospitalización.
- B. Al uso, con carácter general, de habitación individual.
- C. Al acompañamiento espiritual.
- D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respuesta correcta: D**Comentario:**

Al acompañamiento de familiares y personas allegadas en los procesos con hospitalización, así como el uso, con carácter general, de habitación individual, para preservar su intimidad y, en su caso, el acompañamiento espiritual.

PREGUNTA 86

SEGÚN EL DECRETO 147/2015, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA DECLARACIÓN SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI, LA PERSONA PACIENTE O USUARIO:

- A. Debe dejar por escrito las decisiones cuando sea legalmente exigible o recomendable.
- B. Debe dejar por escrito las decisiones cuando se lo solicite el personal profesional que le atiende.
- C. Debe dejar por escrito las decisiones cuando la política del centro sanitario así lo establezca.
- D. Debe dejar por escrito las decisiones cuando puedan tener relevancia a efectos de responsabilidad legal.

Respuesta correcta: A

Comentario:

La persona paciente o usuaria, en relación con su participación responsable en la gestión de su propia salud, dentro del sistema sanitario de Euskadi, deberá de cumplir los siguientes deberes: a) Asumir las propias decisiones sobre su salud, responsabilizándose de las mismas, debiendo dejar por escrito las decisiones cuando sea legalmente exigible o recomendable (consentimiento informado, alta voluntaria, rechazo de tratamiento, etc.).

PREGUNTA 87

SEGÚN EL DECRETO 147/2015, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA DECLARACIÓN SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI, LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PACIENTES Y PERSONAS USUARIAS:

- A. Estarán disponibles en las Organizaciones de Servicios Sanitarios de Osakidetza- Servicio Vasco de Salud, los centros sanitarios concertados, los centros privados y el departamento competente en materia de sanidad.
- B. Estarán disponibles en las Organizaciones de Servicios Sanitarios de Osakidetza- Servicio Vasco de Salud, los centros sanitarios concertados y el departamento competente en materia de sanidad, pero no existe previsión en relación con los centros privados.
- C. Estarán disponibles en las Organizaciones de Servicios Sanitarios de Osakidetza- Servicio Vasco de Salud, pero no existe previsión en relación con los centros concertados, ni con los privados ni con el departamento competente en materia de sanidad.
- D. Estarán disponibles en las Organizaciones de Servicios Sanitarios de Osakidetza- Servicio Vasco de Salud y en los centros sanitarios concertados y privados, pero no existe previsión en relación con el departamento competente en materia de sanidad.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Las Organizaciones de Servicios Sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, los centros sani-

tarios concertados y el departamento competente en materia de sanidad dispondrán de Servicios de atención a pacientes y personas usuarias

PREGUNTA 88

SEGÚN EL DECRETO 147/2015, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA DECLARACIÓN SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI, LAS RECLAMACIONES CONTRA ACTUACIONES DEL PERSONAL:

- A. Se resolverán atendiendo a las normas disciplinarias específicas previa apertura, en su caso, del expediente informativo correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades que de los hechos pudieran derivarse.
- B. Se resolverán atendiendo a las normas disciplinarias generales previa apertura, en su caso, del expediente informativo correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades que de los hechos pudieran derivarse.
- C. Se resolverán atendiendo a las normas disciplinarias específicas previa apertura, en su caso, del expediente informativo y de expediente de mediación, sin perjuicio de las responsabilidades que de los hechos pudieran derivarse.
- D. Se resolverán atendiendo a las normas disciplinarias generales previa apertura, en su caso, del expediente informativo y de expediente de mediación, sin perjuicio de las responsabilidades que de los hechos pudieran derivarse.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Las reclamaciones contra actuaciones del personal se resolverán atendiendo a las normas disciplinarias específicas previa apertura, en su caso, del expediente informativo correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades que de los hechos pudieran derivarse.

PREGUNTA 89

SEGÚN DISPONE LA LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN CLÍNICA, LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA ES:

- A. La información contenida en la historia clínica.
- B. El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial y la documentación relativa a las voluntades anticipadas.
- C. El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial y de investigación biomédica.
- D. El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial.

PREGUNTA 90

SEGÚN DISPONE LA LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA, LA INFORMACIÓN ASISTENCIAL:

- A. Como regla general se proporcionará verbalmente.
- B. Como regla general se proporcionará por escrito.
- C. Como regla general se proporcionará verbalmente y por escrito.
- D. Como regla general se proporcionará por escrito cuando se trate de pacientes menores de edad.

Respuesta correcta: A

Comentario:

La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

PREGUNTA 91

SEGÚN DISPONE LA LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA, LA INFORMACIÓN ASISTENCIAL CONTIENE, COMO MÍNIMO:

- A. La finalidad y la naturaleza de cada intervención.
- B. La finalidad y la naturaleza de cada intervención y sus riesgos.
- C. La finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
- D. La finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos, sus consecuencias y los derechos de las personas pacientes.

Respuesta correcta: C

Comentario:

La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

PREGUNTA 92

SEGÚN DISPONE LA LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN ASISTENCIAL:

- A. La persona facultativa responsable de la persona paciente
- B. La persona facultativa responsable de la persona paciente y el personal profesional que le atienda durante el proceso asistencial o le aplique una técnica o un procedimiento concreto.
- C. La persona facultativa responsable de la persona paciente y el personal de enfermería.
- D. El centro sanitario.

Respuesta correcta: B

Comentario:

El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.

PREGUNTA 93

SEGÚN DISPONE LA LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA, LA PERSONA TITULAR DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN ASISTENCIAL ES:

- A. La persona paciente. También serán informadas las personas vinculadas a ella, por razones familiares o de hecho, en la medida que la persona paciente lo permita de manera expresa o tácita.
- B. La persona paciente. También serán informadas las personas vinculadas a ella, por razones familiares o de hecho, en la medida que la persona paciente lo permita de manera expresa.
- C. La persona paciente. También serán informadas las personas vinculadas a ella, por razones familiares o de hecho, en la medida que la persona paciente lo permita por escrito.
- D. La persona paciente. También serán informadas las personas vinculadas a ella, por razones familiares o de hecho.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Art 5. El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.

PREGUNTA 94

SEGÚN DISPONE LA LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN CLÍNICA, CUANDO EXISTE RIESGO INMEDIATO GRAVE PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA O PSÍQUICA DE LA PERSONA ENFERMA Y NO ES POSIBLE CONSEGUIR SU AUTORIZACIÓN:

- A. El personal facultativo podrá llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud de la persona paciente, con el consentimiento de sus familiares.
- B. El personal facultativo podrá llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud de la persona paciente, con el consentimiento de quien ostente la representación legal.
- C. El personal facultativo podrá llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud de la persona paciente, con autorización judicial.
- D. El personal facultativo podrá llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud de la persona paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos: b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.

PREGUNTA 95

SEGÚN DISPONE LA LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA, EL PERSONAL FACULTATIVO PROPORCIONARÁ A LA PERSONA PACIENTE, ANTES DE RECABAR SU CONSENTIMIENTO ESCRITO, LA INFORMACIÓN BÁSICA SIGUIENTE:

- A. Todos los riesgos en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.

- B. Todos los riesgos, siempre que sean graves, en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.
- C. Todos los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.
- D. Todos los riesgos, siempre que sean probables y graves, en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.

PREGUNTA 96

SEGÚN DISPONE LA LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA, EN CASO DE QUE LA PERSONA PACIENTE NO ACEPTA EL ALTA:

- A. El personal facultativo, previa comprobación del informe clínico correspondiente, oír a la persona paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento de la dirección del centro para que confirme o revoque la decisión.
- B. El personal facultativo, previa comprobación del informe clínico correspondiente, oír a la persona paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial para que confirme o revoque la decisión.
- C. La dirección del centro, previa comprobación del informe clínico correspondiente, oír a la persona paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial para que confirme o revoque la decisión.
- D. La dirección del centro, previa comprobación del informe clínico correspondiente, oír a la persona paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento de la autoridad ad-

ministrativa competente para que confirme o revoque la decisión.

Respuesta correcta: C

Comentario:

En el caso de que el paciente no acepte el alta, la dirección del centro, previa comprobación del informe clínico correspondiente, oír al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento del juez para que confirme o revoque la decisión.

PREGUNTA 97

SEGÚN DISPONE LA LEY 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD, LA EXPRESIÓN DE LOS OBJETIVOS VITALES Y VALORES PERSONALES TIENE COMO FIN:

- A. Conocer la voluntad de la persona paciente en relación con la administración de sedación.
- B. Conocer la voluntad de la persona paciente en relación con la finalización de tratamientos de soporte vital.
- C. Ayudar a interpretar las instrucciones y servir de orientación para la toma de decisiones clínicas.
- D. Documentar la actuación del personal profesional sanitario a efectos de responsabilidad legal en situaciones donde la persona paciente no puede expresar su voluntad por sí misma.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Art. 2.2 La expresión de los objetivos vitales y valores personales tiene como fin ayudar a interpretar las instrucciones y servir de orientación para la toma de decisiones clínicas llegado el momento.

PREGUNTA 98

SEGÚN DISPONE LA LEY 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD, EN EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS:

- A. Se podrá designar una o varias personas representantes para que sean las interlocutoras

válidas del personal facultativo o del equipo sanitario.

- B. Se podrá designar exclusivamente una persona representante para que sea la interlocutora válida del personal facultativo o del equipo sanitario.
- C. Se podrá designar una o varias personas representantes para que sean las interlocutoras válidas del personal facultativo o del equipo sanitario, si la persona paciente es menor de edad.
- D. Se podrá designar una o varias personas representantes para que sean las interlocutoras válidas del personal facultativo o del equipo sanitario y facultarles para interpretar sus valores e instrucciones, si la persona paciente está incapacitada judicialmente.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Art.3 podrá designar uno o varios representantes para que sean los interlocutores válidos del médico o del equipo sanitario y facultarles para interpretar sus valores e instrucciones.

PREGUNTA 99

SEGÚN LA LEY 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD, SI EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN EL DOCUMENTO DE INSTRUCCIONES PREVIAS HA RECAÍDO EN FAVOR DE LA PERSONA CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO DE LA PERSONA OTORGANTE:

- A. Se extingue a partir, bien de la interposición de la demanda de nulidad, separación matrimonial o divorcio, bien de la extinción formalizada de la pareja de hecho o unión libre. Para el mantenimiento de la designación será necesario, en caso de nulidad, separación matrimonial o divorcio, que conste expresamente en la resolución judicial dictada al efecto.
- B. Se extingue a partir bien de la nulidad, separación matrimonial o divorcio, bien de la extinción formalizada de la pareja de hecho o unión libre. Para el mantenimiento de la designación será necesario, en caso de nulidad, separación ma-

rimonial o divorcio, que conste expresamente en la resolución judicial dictada al efecto.

- C. Se extingue a partir, bien de la interposición de la demanda de nulidad, separación matrimonial o divorcio, bien de la extinción formalizada de la pareja de hecho o unión libre. Para el mantenimiento de la designación será necesario, en caso de nulidad, separación matrimonial o divorcio, que conste expresamente en el documento de instrucciones previas.
- D. Se extingue bien a partir de la nulidad, separación matrimonial o divorcio, bien de la extinción formalizada de la pareja de hecho o unión libre. Para el mantenimiento de la designación será necesario, en caso de nulidad, separación matrimonial o divorcio, que conste expresamente en el documento de instrucciones previas.

Respuesta correcta: A

Comentario:

El nombramiento de representante que haya recaído en favor del cónyuge o pareja de hecho de la persona otorgante se extingue a partir, bien de la interposición de la demanda de nulidad, separación matrimonial o divorcio, bien de la extinción formalizada de la pareja de hecho o unión libre. Para el mantenimiento de la designación será necesario, en caso de nulidad, separación matrimonial o divorcio, que conste expresamente en la resolución judicial dictada al efecto. En el supuesto de extinción formalizada de la pareja de hecho o unión libre, será necesaria la manifestación expresa en un nuevo documento.

PREGUNTA 100

SEGÚN DISPONE LA LEY 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD, LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL TRATAMIENTO PUEDEN REFERIRSE:

- A. A una enfermedad o lesión que la persona otorgante ya padece o a las que eventualmente podría padecer en un futuro.
- B. Exclusivamente a una enfermedad o lesión que la persona otorgante ya padece.

- C. Exclusivamente a una enfermedad o lesión que la persona otorgante eventualmente podría padecer en un futuro
- D. Exclusivamente a una enfermedad o lesión que la persona otorgante eventualmente podría padecer en un futuro, siempre que sea de carácter grave.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Las instrucciones sobre el tratamiento pueden referirse tanto a una enfermedad o lesión que la persona otorgante ya padece como a las que eventualmente podría padecer en un futuro, e incluir previsiones relativas a las intervenciones médicas acordes con la buena práctica clínica que desea recibir, a las que no desea recibir y a otras cuestiones relacionadas con el final de la vida.

PREGUNTA 101

SEGÚN DISPONE LA LEY 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD, EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS:

- A. Se formaliza por escrito y mediante uno de los siguientes procedimientos a elección de la persona que lo otorga: ante una notaría; ante la persona funcionaria o empleada pública encargada del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas; o ante dos testigos.
- B. Se formaliza por escrito y mediante uno de los siguientes procedimientos a elección de la persona que lo otorga: ante una notaría; ante la persona funcionaria o empleada pública encargada del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas; o ante tres testigos.
- C. Se formaliza por escrito y mediante uno de los siguientes procedimientos a elección de la persona que lo otorga: ante una notaría; ante la persona funcionaria o empleada pública encargada del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas o del servicio de documentación de un centro sanitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco; o ante dos testigos.
- D. Se formaliza por escrito y mediante uno de

los siguientes procedimientos a elección de la persona que lo otorga: ante una notaría; ante la persona funcionaria o empleada pública encargada del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas o del servicio de documentación de un centro sanitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco; o ante tres testigos.

Respuesta correcta: B

Comentario:

- 2. El documento se formaliza por escrito y mediante uno de los siguientes procedimientos a elección de la persona que lo otorga:
 - a. Ante notario.
 - b. Ante el funcionario o empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.
 - c. Ante tres testigos.

PREGUNTA 102

SEGÚN DISPONE LA LEY 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD, EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS PUEDE SER MODIFICADO, SUSTITUIDO POR OTRO O REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA PERSONA OTORGANTE:

- A. Siempre que conserve la capacidad o actúe con la asistencia de su representante legal y actúe libremente.
- B. Siempre que conserve la capacidad o exista autorización judicial.
- C. Siempre que actúe libremente.
- D. Siempre que conserve la capacidad y actúe libremente.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Art 4. El documento de voluntades anticipadas puede ser modificado, sustituido por otro o revocado en cualquier momento por la persona otorgante, siempre que conserve la capacidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de esta ley y actúe libremente (Cualquier persona mayor de edad que no haya sido judicialmente incapacitada para ello y actúe libremente).

PREGUNTA 103

SEGÚN DISPONE LA LEY 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD, LA VOLUNTAD DE LA PERSONA PREVALECE SOBRE LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS ANTE CUALQUIER INTERVENCIÓN CLÍNICA SIEMPRE QUE:

- A. La persona otorgante conserve su capacidad y su libertad de actuación.
- B. La persona otorgante conserve su capacidad, su libertad de actuación y la posibilidad de expresarse.
- C. La persona otorgante conserve su capacidad, su libertad de actuación y la posibilidad de expresarse de manera inequívoca.
- D. La persona otorgante conserve su capacidad, su libertad de actuación y la posibilidad de expresarse de manera inequívoca o a través de la persona interlocutora designada al efecto.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Mientras la persona otorgante conserve su capacidad, según lo dispuesto en el artículo 2.1 de esta ley, su libertad de actuación y la posibilidad de expresarse, su voluntad prevalece sobre las instrucciones contenidas en el documento de voluntades anticipadas ante cualquier intervención clínica.

PREGUNTA 104

SEGÚN DISPONE LA LEY 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD, EN EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS SE TENDRÁN POR NO PUESTAS:

- A. Las instrucciones que en el momento de ser aplicadas resulten contrarias al ordenamiento jurídico.
- B. Las instrucciones que en el momento de ser otorgadas resulten contrarias al ordenamiento jurídico.
- C. Las respuestas a) y b) son correctas.
- D. Las instrucciones que en el momento de ser aplicadas no se aprueben por el comité de ética del centro.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Se tendrán por no puestas las instrucciones que en el momento de ser aplicadas resulten contrarias al ordenamiento jurídico o no se correspondan con los tipos de supuestos previstos por la persona otorgante al formalizar el documento de voluntades anticipadas

PREGUNTA 105

SEGÚN DISPONE LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES, PODRÁN TENER ACCESO A LOS DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS FALLECIDAS:

- A. Las personas vinculadas a la persona fallecida por razones familiares o de hecho así como quienes ostenten la condición de herederos, en todo caso.
- B. Solo las personas vinculadas a la persona fallecida por razones familiares siempre que lo hubiera autorizado expresamente la persona fallecida.
- C. Las personas vinculadas a la persona fallecida por razones familiares o de hecho así como quienes ostenten la condición de herederos, salvo que la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente.
- D. En caso de que la persona fallecida fuera menor de edad, el acceso podrá ejercerse también por sus representantes legales o por el Ministerio Fiscal que siempre actuará de oficio.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Art. 4. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión. Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará

al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.

PREGUNTA 106

SEÑALE LA RESPUESTA QUE NO ES CORRECTA. SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES A EFECTOS DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS, EL CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA AFECTADA TIENE QUE SER UNA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD QUE CUMPLA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- A. Libre.
- B. Verbal.
- C. Específica.
- D. Informada.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Art 6. Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

PREGUNTA 107

CON RELACIÓN AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE UNA PERSONA MENOR DE EDAD, SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:

- A. Únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciséis años.
- B. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales no prevé que las personas menores de edad puedan dar su consentimiento válidamente a estos efectos.
- C. Únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
- D. El tratamiento de los datos de las personas menores de dieciséis años, fundado en el

consentimiento, solo será lícito si consta el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o tutela, con el alcance que dichas personas determinen.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Art. 7. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.

PREGUNTA 108

LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES, EN SU ARTÍCULO 9 CONSIDERA CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS AQUELLOS QUE PERMITAN, RESPECTO A LA PERSONA AFECTADA, IDENTIFICAR:

- A. Su ideología y afiliación sindical.
- B. Su religión y orientación sexual.
- C. Sus creencias u origen racial o étnico.
- D. Todas las respuestas son correctas.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Artículo 9. Categorías especiales de datos. 1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.

PREGUNTA 109

LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES ESTABLECE QUE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE NATURALEZA PENAL PODRÁ LLEVARSE A CABO:

- A. Solo por profesionales de la abogacía y cuando tengan por objeto recoger la información facilitada por quienes les contraten para el ejercicio de sus funciones.

- B. Por profesionales de la abogacía y de la procura, cuando tengan por objeto recoger la información facilitada por quienes les contraten para el ejercicio de sus funciones.
- C. En los casos previstos por la propia Ley Orgánica 3/2018 y en otras normas de rango reglamentario.
- D. Exclusivamente en los supuestos amparados en una norma de Derecho de la Unión y en la propia Ley Orgánica 2/2018.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal. 1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. 3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

PREGUNTA 110

RESPECTO AL DERECHO DE RECTIFICACIÓN QUE REGULA LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES, SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:

- A. La persona afectada deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y deberá acompañar, en todo caso, la documentación justificativa de la inexactitud de los datos.
- B. La persona afectada deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse, y cuando sea preciso, deberá acompañar la documentación justificativa

de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

- C. La persona afectada deberá indicar en su solicitud solo la corrección que haya de realizarse y debe siempre acompañar la documentación justificativa de la inexactitud de los datos.
- D. No es necesario que la persona afectada indique expresamente en su solicitud qué datos deben rectificarse.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

PREGUNTA 111

CON RELACIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS CON FINES DE VIDEOVIGILANCIA, SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:

- A. Solo las personas físicas podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como sus instalaciones.
- B. Los datos serán suprimidos, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde su captación.
- C. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
- D. En el caso de que los datos hubieran de ser conservados más allá del plazo de un mes desde su captación para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Art 22. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación

PREGUNTA 112

RESPECTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE DENUNCIAS INTERNAS QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES, ES CORRECTA LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN:

- A. En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos.
- B. En todo caso, transcurridos seis meses desde la introducción de los datos, deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos.
- C. En todo caso, y sin excepción, transcurridos seis meses desde la introducción de los datos, deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias.
- D. La Ley no prevé plazo temporal alguno para la supresión de los datos del sistema de denuncias.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Art 24 (antiguo). En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica.

PREGUNTA 113

EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/2023, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES, AÑADE UN CONCEPTO ESPECÍFICO AL OBJETO DE LA LEY QUE REFUERZA EL FIN ÚLTIMO DE LA NORMA, ¿CUÁL ES?

- A. La igualdad de oportunidades.
- B. El empoderamiento de las mujeres.
- C. Lograr una sociedad libre de violencia machista.
- D. La eliminación de roles tradicionales.

Respuesta correcta: C

Comentario:

El artículo 1 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, establece que el fin último de la norma es lograr una sociedad igualitaria y libre de violencia machista contra las mujeres, reforzando así el objetivo global de la ley más allá de la mera igualdad formal. Aunque la norma también incorpora conceptos como el empoderamiento de las mujeres y la eliminación de la desigualdad estructural, el elemento que expresa de forma directa el fin último perseguido es la construcción de una sociedad libre de violencia machista, lo que orienta todas las medidas previstas hacia la erradicación de esta forma de violencia y la consecución de una igualdad real y efectiva.

PREGUNTA 114

SEGÚN EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/2023, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES, ¿A QUÉ ENTIDADES PRIVADAS LES ES EXIGIBLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE ESTA LEY DURANTE SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN?

- A. Solo a las que tengan una plantilla superior a 250 personas.
- B. A todas las empresas con sede en Euskadi.
- C. A las que suscriban contratos o convenios, estén participadas por poderes públicos o sean beneficiarias de ayudas.

D. Ninguna entidad privada está sujeta a los principios de la ley.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Las entidades privadas sujetas a los principios de la ley son las que suscriben contratos o convenios con poderes públicos, están participadas por poderes públicos o reciben subvenciones de ellos (DL 1/2023, art. 2). Las opciones 1, 2 y 4 son incorrectas respecto al ámbito de aplicación a entidades privadas.

PREGUNTA 115

SEGÚN EL DECRETO LEGISLATIVO 1/2023, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES, ¿CUÁL DE ESTOS ES UN PRINCIPIO GENERAL DE ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS VASCOS INCORPORADO EN LA NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 3?

- A. El principio de jerarquía administrativa.
- B. La integración de la perspectiva interseccional.
- C. El principio de celeridad procesal.
- D. La centralización de recursos de acogida.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Artículo 3. Principios generales. Los principios generales que deben regir y orientar la actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres son los siguientes: la igualdad de trato; la igualdad de oportunidades; la prevención y erradicación de la violencia machista contra las mujeres; el respeto a la diversidad y a la diferencia; la integración de la perspectiva de género; la acción positiva; la eliminación de roles y estereotipos en función del género; la integración de la perspectiva interseccional; el libre desarrollo de la identidad sexual o de género, la orientación sexual, la autonomía corporal y la autodeterminación; la representación equilibrada; la colabo-

ración y coordinación e internacionalización; el empoderamiento de las mujeres; la implicación de los hombres; la participación; la innovación, transparencia y rendición de cuentas; la protección de los derechos lingüísticos y la promoción del uso del euskera.

PREGUNTA 116

SEGÚN EL DECRETO LEGISLATIVO 1/2023, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES, RESPECTO AL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA, ¿EN QUÉ CASO SE PERMITE EXCEPCIONALMENTE UNA PRESENCIA DE MUJERES SUPERIOR AL 60%?

- A. En ningún caso.
- B. Solo si no hay hombres capacitados en el sector.
- C. Cuando sea acorde al objetivo de corregir la histórica situación de infrarrepresentación de las mujeres.
- D. Si el órgano tiene menos de cuatro integrantes.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Cuando, existiendo una representación de mujeres superior al 60 % en el órgano, esa sobrerrepresentación se considere acorde al objetivo de corregir la histórica situación de desigualdad que han sufrido las mujeres, derivada de su infrarrepresentación en los ámbitos de toma de decisiones.

PREGUNTA 117

SEGÚN EL DECRETO LEGISLATIVO 1/2023, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES, ¿QUÉ PLANES ESPECÍFICOS DEBEN SOMETERSE AHORA, OBLIGATORIAMENTE, A UNA EVALUACIÓN PREVIA DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO?

- A. Solo los planes de formación interna.
- B. Los planes territoriales y urbanísticos.

- C. Los planes de marketing de empresas públicas.
- D. Ningún plan, solo los proyectos de ley.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Art. 20. Los planes que tengan naturaleza jurídica de disposiciones de carácter general, en particular los territoriales y urbanísticos, deben ser objeto de evaluación previa de impacto en función del género e incluir medidas para promover la igualdad.

PREGUNTA 118

SEGÚN EL DECRETO LEGISLATIVO 1/2023, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES, ¿QUÉ REQUISITO NUEVO DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS DE MÁS DE 50 PERSONAS TRABAJADORAS PARA PODER RECIBIR SUBVENCIONES PÚBLICAS?

- A. Tener paridad total en su directiva.
- B. Acreditar haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y las violencias sexuales.
- C. Tener un departamento exclusivo de igualdad.
- D. Estar inscritas en un registro internacional de igualdad.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Art 23. Tampoco podrán recibir ayudas o subvenciones las empresas que, debiendo tener un plan de igualdad vigente según la normativa del Estado, no lo tengan, ni aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y las violencias sexuales en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres.

PREGUNTA 119

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES, APROBADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1/2023, DE 16 DE MARZO, ¿CÓMO SE DEFINE LA “VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES”?

- A. Solo la violencia física en el hogar.
- B. Una violación de los derechos humanos y un problema de salud pública de primer orden.
- C. Únicamente los delitos contra la libertad sexual.
- D. Un conflicto de convivencia familiar.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Art 54. La violencia machista contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, un problema social y de salud pública de primer orden y una manifestación de las desiguales relaciones de poder y de la discriminación contra las mujeres que desempeña, además, la función social de perpetuar las desigualdades estructurales que existen en función del género.

PREGUNTA 120

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54.3 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES, APROBADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1/2023, DE 16 DE MARZO, ¿QUÉ FORMAS DE VIOLENCIA SE INCORPORAN COMO CASOS CONSTITUTIVOS DE VIOLENCIA MACHISTA POR ESTAR ESPECÍFICAMENTE RECOGIDOS EN DICHO APARTADO?

- A. Solo la violencia física y psicológica.
- B. La violencia obstétrica, la política de género y la violencia digital.
- C. Únicamente el acoso laboral.
- D. No se detallan formas, se remite al Código Penal.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Constituyen violencia machista contra las mujeres la violencia en la pareja o expareja, la in-

trafamiliar, la violencia sexual, el feminicidio, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y otras prácticas tradicionales perjudiciales, la coacción o privación arbitraria de libertad, la tortura, la violencia institucional, el acoso, la violencia política de género, la violencia digital y en redes sociales, la obstétrica, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, así como cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres y niñas que se halle prevista en los tratados internacionales, en el Código Penal español o en la normativa estatal o autonómica.

PREGUNTA 121

¿CUÁNTOS OBJETIVOS GENERALES, CLASIFICADOS COMO FINALISTAS E INSTRUMENTALES, SE DEFINEN EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030?

- A. Cinco Objetivos Generales.
- B. Seis Objetivos Generales.
- C. Siete Objetivos Generales.
- D. Ocho Objetivos Generales.

Respuesta correcta: C

Comentario:

El Plan de Salud Euskadi 2030 define siete Objetivos Generales, clasificados como finalistas e instrumentales (Plan de Salud Euskadi 2030).

PREGUNTA 122

SEGÚN EL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030, LA VISIÓN QUE SE ASPIRA A LOGRAR COMO PAÍS ES:

- A. Convertirnos en el sistema de salud pública más sólido y resiliente de Europa.
- B. Liderar una Euskadi más saludable.
- C. Reducir la morbilidad evitable y disminuir las desigualdades en salud antes de 2030.
- D. Lograr la sostenibilidad y excelencia en los sistemas asistenciales sanitarios y sociosanitarios.

Respuesta correcta: B

Comentario:

La VISIÓN del Plan de Salud Euskadi 2030 es liderar una Euskadi más saludable.

PREGUNTA 123

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES UN PRINCIPIO RECTOR EN LOS QUE SE APOYA EL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030?

- A. La necesaria coordinación y colaboración interinstitucional, entre agentes y en todos los niveles.
- B. Enfoque de Salud en Todas las Políticas y 'Una Sola Salud' ('One Health').
- C. La autosuficiencia presupuestaria del Sistema Sanitario Público.
- D. Contribución al Desarrollo Sostenible.

Respuesta correcta: C

Comentario:

La autosuficiencia presupuestaria del Sistema Sanitario Público NO es un principio rector del Plan de Salud Euskadi 2030; los principios son la coordinación interinstitucional, el enfoque 'Una Sola Salud' y la contribución al Desarrollo Sostenible sí son principios reconocidos.

PREGUNTA 124

EL OBJETIVO GENERAL 1 (OG1) DEL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030 SE ENFOCA EN:

- A. Promover la salud de las mujeres y la salud reproductiva en la edad adulta.
- B. Lograr que niñas, niños y adolescentes nazcan, crezcan y se desarrollen con todo su potencial de salud.
- C. Mejorar la salud mental y reducir la morbilidad asociada a trastornos mentales.
- D. La prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (ENT).

Respuesta correcta: B

Comentario:

El Objetivo General 1 del Plan de Salud Euskadi 2030 se enfoca en lograr que niñas, niños y ado-

lescentes nazcan, crezcan y se desarrollen en las mejores condiciones de salud posibles.

PREGUNTA 125

EL OBJETIVO GENERAL 4 (OG4) DEL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030 SE DEFINE COMO “LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD Y EXCELENCIA EN LOS SISTEMAS ASISTENCIALES SANITARIOS Y SOCIOASISTENCIALES DE EUSKADI”, ¿EN TÉRMINOS DE QUÉ TRES CONCEPTOS CLAVE?

- A. Eficiencia, accesibilidad e innovación.
- B. Calidad, humanización y seguridad.
- C. Equidad, intersectorialidad y coordinación.
- D. Investigación, formación y evaluación.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Objetivo general 4: Lograr la sostenibilidad y Excelencia en términos de calidad, humanización y seguridad en los sistemas asistenciales sanitarios y sociosanitarios de Euskadi.

PREGUNTA 126

¿A QUÉ HACE REFERENCIA EL ACRÓNIMO AVAD EN EL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030?

- A. Áreas de Valoración de la Atención al Dependiente.
- B. Años de Vida Activa Desaprovechados.
- C. Atención Vasca a la Adicción a Drogas.
- D. Años de Vida sana perdidos Ajustados por Discapacidad.

Respuesta correcta: D

Comentario:

AVAD significa Años de Vida sana perdidos Ajustados por Discapacidad.

PREGUNTA 127

¿CUÁL ES UNO DE LOS OBJETIVOS CLAVE DEL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030, REITERADO EN VARIAS SECCIONES, RESPECTO A LA EQUIDAD Y LA GESTIÓN DE LA ENFERMEDAD?

- A. Garantizar la participación de la empresa privada en la gestión de servicios hospitalarios.

- B. Aumentar la esperanza de vida en 5 años en todos los colectivos sociales.
- C. Reducir la morbilidad evitable y disminuir las desigualdades en salud.
- D. Implementar un programa de cribado universal para todos los tipos de cáncer.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Un objetivo clave reiterado en el Plan de Salud Euskadi 2030 es reducir la morbilidad evitable y disminuir las desigualdades en salud.

PREGUNTA 128

¿QUÉ ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN PRIORIZA EL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030 PARA ASEGURAR QUE LOS AVANCES CIENTÍFICOS LLEGUEN DE FORMA EFECTIVA A LA PRÁCTICA CLÍNICA Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN?

- A. Enfoque de investigación básica y fundamental.
- B. Enfoque de investigación traslacional.
- C. Enfoque de investigación puramente epidemiológica.
- D. Enfoque de investigación competitiva internacional.

Respuesta correcta: B

Comentario:

El Plan de Salud Euskadi 2030 prioriza el enfoque de investigación traslacional, que lleva los conocimientos generados en el laboratorio a la práctica clínica y a las políticas de salud.

PREGUNTA 129

SEGÚN EL MODELO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030, ¿CUÁLES SON LOS CUATRO CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA DETERMINAR EL ÉXITO DE LAS INTERVENCIONES?

- A. Impacto, cobertura, equidad y transparencia.
- B. Relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad.
- C. Rentabilidad, participación, innovación y prestigio.
- D. Calidad, calidez, rapidez y ahorro presupuestario.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Los cuatro criterios de evaluación del Plan de Salud Euskadi 2030 son relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad: El propósito de la evaluación consiste en determinar la relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad de las intervenciones llevadas a cabo y sus resultados en la población diana.

PREGUNTA 130

EN LA LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES, ¿QUÉ TIPO DE SOLUCIONES HABITACIONALES PROMUEVE EL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030 PARA LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA?

- A. Construcción de viviendas de protección oficial exclusivamente rurales.
- B. Soluciones habitacionales asequibles, accesibles y adaptadas al ciclo vital.
- C. Ayudas directas al alquiler únicamente para personas menores de 30 años.
- D. Fomento de grandes centros residenciales para todas las personas con enfermedades crónicas.

Respuesta correcta: B

Comentario:

El Plan de Salud Euskadi 2030 promueve soluciones habitacionales asequibles, accesibles y adaptadas al ciclo vital de las personas para combatir las desigualdades en salud.

PREGUNTA 131

SEGÚN LA COMPARATIVA DE LA MEMORIA ECONÓMICA DEL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030, ¿CUÁL ES EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (FUERA DEL GASTO GENERAL DE OSAKIDETZA) CON MAYOR DOTACIÓN?

- A. Programa de Salud Pública.
- B. Programa de Farmacia.
- C. Programa de Adicciones.
- D. Programa de Investigación y Planificación.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Según la Memoria Económica del Plan de Salud Euskadi 2030, el Programa de Farmacia representa el mayor porcentaje del presupuesto sanitario vasco el programa de Salud Pública, con una dotación en 2023 de 30.163.163 euros, el programa de Adicciones con 3.885.451 euros, el de Investigación y Planificación sanitarias, con 17.272.840 euros y el de Farmacia, con un presupuesto reservado para gasto farmacéutico que alcanza 546.400.691 euros.

PREGUNTA 132

EL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030 BUSCA LOGRAR “COMUNIDADES AMIGABLES” PARA LAS PERSONAS MAYORES. ¿CUÁL ES LA FINALIDAD ÚLTIMA DE ESTA ESTRATEGIA?

- A. Segregar los espacios públicos por franjas de edad.
- B. Adaptar el entorno físico y social para fomentar un envejecimiento activo y con sentido.
- C. Aumentar el número de plazas en residencias geriátricas de alta especialización.
- D. Limitar el acceso de vehículos a las zonas cercanas a los centros de salud.

Respuesta correcta: B

Comentario:

El Plan busca adaptar el entorno físico y social para fomentar un envejecimiento activo, saludable e inclusivo en comunidades amigables para las personas mayores.

PREGUNTA 133

EN EL ÁMBITO DE LA SALUD DIGITAL, ¿QUÉ CONCEPTO DESTACA EL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030 PARA TRANSFORMAR LA ATENCIÓN PERSONALIZADA?

- A. La teleasistencia robótica obligatoria en todos los domicilios.
- B. La medicina de precisión y la integración de datos genómicos.
- C. La eliminación definitiva de la historia clínica en papel en favor del PDF.
- D. La creación de una red social exclusiva para pacientes crónicos/as.

Respuesta correcta: B

Comentario:

En el ámbito de la salud digital, el Plan de Salud Euskadi 2030 destaca la medicina de precisión y la integración de datos genómicos como herramienta para personalizar la atención.

PREGUNTA 134

¿CÓMO DEFINE EL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030 EL CONCEPTO DE “INTERSECTORIALIDAD” EN LA GESTIÓN DE LA SALUD?

- A. La competencia entre diferentes sectores para obtener fondos públicos.
- B. La colaboración entre departamentos del Gobierno para que la salud esté en todas las políticas.
- C. La privatización de sectores sanitarios no críticos.
- D. La creación de un único departamento que gestione salud, educación y vivienda.

Respuesta correcta: B

Comentario:

El Plan define intersectorialidad como la colaboración entre departamentos del Gobierno para que la salud esté presente en todas las políticas públicas (“Salud en Todas las Políticas”) “Las líneas de actuación son intersectoriales, concerniendo principalmente a otros Departamento y entidades diferentes al Departamento de Salud.”

PREGUNTA 135

¿CUÁL ES LA VISIÓN DEL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030 SOBRE EL USO DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA EN LA TOMA DE DECISIONES POLÍTICAS?

- A. Es un elemento opcional supeditado a la oportunidad política.
- B. Es la base fundamental para el diseño, implementación y evaluación de las políticas de salud.
- C. Solo se debe aplicar en casos de alertas sanitarias internacionales.
- D. Se reserva exclusivamente para el ámbito académico, no para el legislativo.

Respuesta correcta: B

Comentario:

La evidencia científica es la base fundamental para el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas e intervenciones del Plan de Salud Euskadi 2030.

PREGUNTA 136

SEGÚN EL ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL DEL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DEL PACTO VASCO DE SALUD DE EUSKADI, ¿QUÉ FACTOR SE IDENTIFICA COMO UN MOTOR CLAVE PARA QUE LA CIUDADANÍA DEL SIGLO XXI DEMANDE UN PAPEL MÁS ACTIVO EN SU SALUD?

- A. El incremento exclusivo de la esperanza de vida al nacer.
- B. El acceso generalizado a la información y un mayor nivel educativo en la CAPV.
- C. La reducción drástica de las listas de espera en consultas externas.
- D. La implementación de la receta electrónica en todas las farmacias.

Respuesta correcta: B

Comentario:

El Diagnóstico del Pacto Vasco de Salud señala el acceso generalizado a la información y un mayor nivel educativo en la población como factores de transformación social relevantes para la salud: “Los y las ciudadanas del siglo XXI son personas con amplias posibilidades de acceso a la información, disponen en la CAPV de un nivel educativo que les permite obtener de forma activa, comprender y analizar la información con relación a la salud”.

PREGUNTA 137

EL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DEL PACTO VASCO DE SALUD DE EUSKADI SEÑALA QUE LOS FLUJOS MIGRATORIOS ACTUALES EN EUSKADI:

- A. No tienen impacto relevante en el perfil epidemiológico de la comunidad.
- B. Revelan patologías anteriormente poco conocidas en nuestro entorno, pero prevalentes en otras latitudes.

- C. Se limitan exclusivamente a personas en edad laboral con excelente estado de salud inicial.
- D. Han provocado la saturación irreversible de los servicios de urgencias hospitalarias.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Los flujos migratorios revelan patologías anteriormente poco conocidas en nuestro entorno, pero también aportan diversidad cultural y perspectivas de salud enriquecedoras.

PREGUNTA 138

¿CUÁL ES UNO DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS IDENTIFICADOS EN EL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DEL PACTO VASCO DE SALUD DE EUSKADI RESPECTO A LA FORMACIÓN Y RELEVO DEL PERSONAL SANITARIO?

- A. La excesiva oferta de plazas MIR en todas las especialidades médicas.
- B. La falta de interés de las nuevas generaciones por las profesiones biosanitarias.
- C. La necesidad de planificar el relevo ante la jubilación de cohortes numerosas de profesionales.
- D. La prohibición de la formación continua dentro del horario laboral.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Uno de los principales desafíos identificados en el Diagnóstico es la necesidad de planificar el relevo profesional ante la jubilación de cohortes numerosas de sanitarios.

PREGUNTA 139

SOBRE EL IMPACTO DEL CAMBIO GLOBAL Y CLIMÁTICO, EL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DEL PACTO VASCO DE SALUD DE EUSKADI ADVIERTE DE LA APARICIÓN DE:

- A. Patologías ligadas exclusivamente al consumo de alimentos ultraprocesados.
- B. Nuevos vectores y virus anteriormente inexistentes en nuestro entorno, como el virus del Nilo.

- C. Una disminución natural de las enfermedades respiratorias debido al aumento de temperaturas.
- D. La erradicación total de las enfermedades infecciosas estacionales.

Respuesta correcta: B

Comentario:

El cambio climático introduce nuevos vectores y virus anteriormente no presentes en nuestro entorno, así como el retorno de enfermedades que se consideraban erradicadas.

PREGUNTA 140

EL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DEL PACTO VASCO DE SALUD DE EUSKADI PROPONE QUE LOS INDICADORES SANITARIOS PARA EVALUAR EL SISTEMA DEBEN:

- A. Basarse exclusivamente en mediciones de actividad (número de consultas y cirugías).
- B. Ser confidenciales y accesibles únicamente para la alta dirección del Departamento de Salud.
- C. Ignorar la perspectiva de género para simplificar la toma de datos estadísticos.
- D. Reflejar resultados en salud y sostenibilidad, y no solo volumen de actividad.

Respuesta correcta: D

Comentario:

El Diagnóstico propone que los indicadores reflejen resultados en salud y sostenibilidad, y no solo volumen de actividad o número de procedimientos.

PREGUNTA 141

¿CUÁL ES LA FINALIDAD PRINCIPAL DE LOS VALORES FUNDAMENTALES DEL PACTO VASCO DE SALUD, SEGÚN EL LIBRO DE VALORES Y PRINCIPIOS?

- A. Ser la base para la elaboración del futuro Plan Estratégico de Osakidetza.
- B. Establecer la estructura financiera y la autonomía de gestión del sistema de salud.
- C. Ser el fundamento ético y social que soporta la actividad del Sistema Público de Salud de Euskadi.

- D. Garantizar la cobertura universal únicamente a la ciudadanía vasca empadronada.

Respuesta correcta: C

Comentario:

La finalidad principal de los Valores Fundamentales del Pacto Vasco de Salud es ser el fundamento ético y social que soporta la actividad del sistema sanitario vasco.

PREGUNTA 142

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES UN VALOR FUNDAMENTAL EXPLÍCITO DEL PACTO VASCO DE SALUD, ADEMÁS DE LA UNIVERSALIDAD Y LA EQUITAD?

- A. La Sostenibilidad del sistema.
- B. La Eficiencia en el gasto.
- C. La Corresponsabilidad.
- D. El Plurilingüismo como eje central de la atención.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Valores del Sistema público de Salud según Pacto Vasco de Salud son: Universalidad, Solidaridad, Equidad, Autonomía (Pacto 2025).

PREGUNTA 143

EL PRINCIPIO DE INNOVACIÓN EN EL PACTO VASCO DE SALUD SE APLICA A:

- A. Exclusivamente a la aplicación de nuevas tecnologías de imagen médica.
- B. La I+D+i en todas las fases y dimensiones de la salud, incluyendo la organizativa y la asistencial.
- C. La importación de modelos de éxito de otros sistemas sanitarios europeos.
- D. La digitalización de la historia clínica en Osakidetza.

Respuesta correcta: B

Comentario:

El principio de Innovación en el Pacto Vasco de Salud se aplica a la I+D+i en todas las fases y dimensiones de la salud, incluyendo la organización y los modelos de atención. Innovación organizativa

y modelos asistenciales: Incentivar una asistencia integral e integrada para mayor eficiencia.

PREGUNTA 144

EN EL MARCO DEL PACTO VASCO DE SALUD, DENTRO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES, LA “ORIENTACIÓN AL VALOR” SIGNIFICA QUE EL SISTEMA DEBE PRIORIZAR:

- A. Las intervenciones que generen los mejores resultados relevantes para la persona al menor coste posible.
- B. El valor de mercado de las acciones de las empresas proveedoras de tecnología.
- C. El incremento constante de las infraestructuras físicas sobre la inversión en personal.
- D. La compra masiva de medicamentos de marca sobre los genéricos.

Respuesta correcta: A

Comentario:

La ‘Orientación al Valor’ en el Pacto Vasco de Salud se refiere a las intervenciones que generen los mejores resultados relevantes para las personas y la población en relación con los recursos utilizados.

PREGUNTA 145

¿EN QUÉ GRANDES ÁMBITOS SE ESTRUCTURAN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PACTO VASCO DE SALUD?

- A. Cinco Líneas Estratégicas: prevención y promoción de la salud; atención a la enfermedad; calidad, innovación y sostenibilidad; desarrollo de las y los profesionales; y Gobernanza.
- B. Seis Líneas Estratégicas: prevención y promoción de la salud; atención a la enfermedad; áreas prioritarias de salud; calidad, innovación y sostenibilidad; desarrollo de las y los profesionales; y transparencia y participación ciudadana.
- C. Seis Líneas Estratégicas: prevención y promoción de la salud; atención a la enfermedad; áreas prioritarias de salud; calidad, innovación y sostenibilidad; desarrollo de las y los profesionales; y gobernanza.
- D. Seis Líneas Estratégicas: prevención y promoción de la salud; atención sociosanitaria;

áreas prioritarias de salud; calidad, innovación y sostenibilidad; desarrollo de las y los profesionales; y gobernanza.

Respuesta correcta: C

Comentario:

A la hora de enfrentarnos a preguntas de legislación o planes estratégicos en una OPE, el índice estructural formal siempre prevalece sobre los párrafos introductorios o resúmenes de prensa.

Si bien es cierto que la introducción del documento del Pacto Vasco de Salud menciona coloquialmente la “transparencia y participación ciudadana”, la estructura oficial que rige el plan denomina al sexto gran ámbito textualmente como VI. Gobernanza.

Este bloque VI de Gobernanza es mucho más amplio y abarca, además de la deliberación ciudadana, aspectos clave como la Colaboración público-privada y los Derechos lingüísticos. Por lo tanto, la opción C es la respuesta más rigurosa, completa y fiel a la arquitectura del documento oficial.

Podéis encontrar lo mencionado en este link: <https://www.euskadi.eus/pacto-vasco-de-salud-de-euskadi/web01-a2salpol/es/>

PREGUNTA 146

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y COMUNITARIA DENTRO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PACTO VASCO DE SALUD?

- A. Actuar como un servicio de triaje rápido para derivar todos los casos al hospital.
- B. Ser un servicio opcional para quienes no dispongan de seguro privado.
- C. Limitarse a la atención administrativa y la gestión de bajas laborales.
- D. Ser la base estratégica que cohesione y sustente todo el sistema de salud vasco.

Respuesta correcta: D

Comentario:

El Pacto Vasco de Salud establece que la Atención Primaria y Comunitaria debe ser la base estratégica que cohesione y sustente todo el sistema de sa-

lud, resolviendo la mayor parte de los problemas de salud de la población.

PREGUNTA 147

EN RELACIÓN CON LA LÍNEA ESTRATÉGICA 06 SOBRE “CRONICIDAD” DEL PACTO VASCO DE SALUD, ¿QUÉ OBJETIVO SE PERSIGUE PRIMORDIALMENTE?

- A. Institucionalizar a todas las personas con enfermedades crónicas en centros especializados.
- B. Reforzar la autonomía y corresponsabilidad de las personas con enfermedades crónicas.
- C. Sustituir las consultas médicas presenciales por seguimiento telefónico automático.
- D. Reducir la cobertura de medicamentos para patologías de larga duración.

Respuesta correcta: B

Comentario:

La Línea Estratégica 06 sobre Cronicidad del Pacto Vasco de Salud busca reforzar la autonomía y corresponsabilidad de las personas con enfermedades crónicas en el manejo de su propia salud. Cronicidad: Mejorar la gestión de enfermedades crónicas y la calidad de vida.

PREGUNTA 148

LA LÍNEA ESTRATÉGICA 07 SOBRE “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA” DEL PACTO VASCO DE SALUD SUBRAYA LA NECESIDAD DE:

- A. Separar definitivamente las competencias de Salud de las de Servicios Sociales.
- B. Mejorar la coordinación y el tránsito de las personas entre el sistema sanitario y el social.
- C. Eliminar las ayudas a la dependencia para fomentar el ahorro público.
- D. Obligar a las personas pacientes a elegir entre atención médica o apoyo social.

Respuesta correcta: B

Comentario:

La Línea Estratégica 07 sobre Atención Sociosanitaria busca mejorar la coordinación y el tránsito de las personas entre el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales. Atención sociosanitaria:

Coordinar el sistema sanitario con servicios sociales para una atención integrada.

PREGUNTA 149

RESPECTO A LA “SALUD MENTAL” (LÍNEA 11), EL PACTO VASCO DE SALUD PONE EL FOCO EN:

- A. La promoción del bienestar emocional y la detección precoz, especialmente en jóvenes.
- B. El aislamiento preventivo de las personas con trastornos mentales graves.
- C. La medicalización sistemática de cualquier malestar emocional de la ciudadanía.
- D. La reducción de la plantilla de psicología en los centros de salud primaria.

Respuesta correcta: A

Comentario:

La Línea Estratégica 11 sobre Salud Mental del Pacto Vasco de Salud pone el foco en la promoción del bienestar emocional y la detección precoz, especialmente en infancia y adolescencia. Salud mental: Promover, prevenir y optimizar el modelo asistencial.

PREGUNTA 150

LA LÍNEA ESTRATÉGICA 18 SOBRE “DIGITALIZACIÓN EN SALUD” DEL PACTO VASCO DE SALUD BUSCA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA:

- A. Reemplazar al personal sanitario por sistemas de inteligencia artificial autónomos.
- B. Eliminar el papel de todos los archivos históricos sin digitalizar previamente.
- C. Facilitar la accesibilidad, la personalización de la atención y la eficiencia organizativa.
- D. Crear una base de datos pública con el historial clínico de toda la ciudadanía.

Respuesta correcta: C

Comentario:

La Línea Estratégica 18 sobre Digitalización busca facilitar la accesibilidad, la personalización de la atención y la eficiencia del sistema mediante el uso de tecnologías digitales. Digitalización en salud: Aplicar tecnología para optimizar atención, planificación, gestión e investigación.

PREGUNTA 151

¿CUÁL ES EL OBJETIVO GENERAL ESTABLECIDO PARA LA “ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 20-30”?

- A. Reducir a cero los eventos adversos mediante la incorporación de tecnología robótica.
- B. Mejorar la calidad asistencial del sistema sanitario vasco.
- C. Promover el máximo nivel de seguridad posible, minimizando la probabilidad de ocurrencia de incidentes de seguridad en el transcurso de la asistencia sanitaria.
- D. Centralizar la gestión de riesgos en un único organismo fuera de Osakidetza.

Respuesta correcta: C

Comentario:

El objetivo general de la Estrategia de Seguridad del Paciente 20-30 de Osakidetza es promover el máximo nivel de seguridad posible, minimizando la probabilidad de que ocurran incidentes de seguridad y reduciendo sus consecuencias.

PREGUNTA 152

EL PRINCIPIO HIPOCRÁTICO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN LA “ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 20-30”, Y QUE LA CIUDADANÍA ASUME QUE SE VERIFICA EN EL TRANSCURSO DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL, ES:

- A. Salus populi suprema lex esto (la salud del pueblo es la ley suprema).
- B. Corpus sanum in mente sana (mente sana en cuerpo sano).
- C. Lex artis ad hoc (ley del arte para el caso).
- D. Primum non nocere (primero no hacer daño).

Respuesta correcta: D

Comentario:

El conjunto de la ciudadanía asume que el principio hipocrático “primum non nocere” se verifica en el transcurso de la actividad asistencial.

PREGUNTA 153

¿CUÁLES SON LAS DOS NUEVAS LÍNEAS DE ACCIÓN INCORPORADAS EN LA “ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 20-30” QUE RESPONDEN A UNA NECESIDAD PERCIBIDA POR LAS PERSONAS EXPERTAS?

- A. Seguridad en Pediatría y Buenas Prácticas en el Uso de Biológicos.
- B. Atención en Cuidados Paliativos y Seguridad Domiciliaria.
- C. La Seguridad de Paciente en Emergencias y la Prevención del Suicidio.
- D. Seguridad en Salud Mental y Prevención de las Úlceras por Presión.

Respuesta correcta: C

Comentario:

La incorporación de dos nuevas líneas de acción en la presente Estrategia:

- la Seguridad del Paciente en Emergencias
- la Prevención del Suicidio responde a una necesidad percibida por las personas expertas que desarrollan su desempeño en esas áreas.

PREGUNTA 154

DE ACUERDO CON LA “ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 20-30”, ¿CÓMO SE DENOMINA AL INCIDENTE DE SEGURIDAD QUE, A DIFERENCIA DEL INCIDENTE SIN DAÑO, SÍ OCASIONA ALGÚN TIPO DE DAÑO A LAS PERSONAS ATENDIDAS?

- A. Error no evitable.
- B. Circunstancia notificable.
- C. Fallo latente.
- D. Evento Adverso.

Respuesta correcta: D

Comentario:

Aprendizaje a partir de los eventos adversos (incidentes de Seguridad con daño)

PREGUNTA 155

¿CUÁL ES EL ENFOQUE PRINCIPAL DE LA LÍNEA DE ACCIÓN CORPORATIVA L2 DE LA “ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 20-30”?

- A. Implicación de pacientes en su seguridad.
- B. Conciliación de la medicación.
- C. Atención a las segundas y terceras víctimas.
- D. Gestión de los incidentes de seguridad.

Respuesta correcta: C

Comentario:

L 2. Atención a las segundas y terceras víctimas...

PREGUNTA 156

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES EL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 1 DE LA “ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 20-30”, ENFOCADO EN EL CAMBIO INTERNO?

- A. Garantizar la continuidad de las líneas de acción y proyectos previamente implantados.
- B. Impulsar la cultura de seguridad de paciente en las organizaciones de servicios de Osakidetza, promoviendo la formación y sensibilización como aspectos clave.
- C. Optimizar la prescripción de pruebas diagnósticas que utilizan radiación ionizante.
- D. Implantar un sistema de identificación inequívoca de pacientes en todas las fases del proceso asistencial.

Respuesta correcta: B

Comentario:

El Objetivo Específico número 1 de la Estrategia SP 20-30 es Impulsar la cultura de Seguridad del Paciente en las organizaciones de servicios de Osakidetza, promoviendo la formación y sensibilización como aspectos clave.

PREGUNTA 157

LA LÍNEA DE ACCIÓN CORPORATIVA L8 DE LA “ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 20-30” ESTÁ DEDICADA A:

- A. Conciliación de la medicación.
- B. Prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
- C. Seguridad en el proceso asistencial gestación-parto-puerperio.
- D. Seguridad transfusional.

Respuesta correcta: B

Comentario:

L 8 Prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.

PREGUNTA 158

¿QUÉ DOCUMENTO SE MENCIONA EN LA “ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 20- 30” COMO EL QUE DETERMINÓ QUE LAS PERSONAS ATENDIDAS POR UN SISTEMA MEDICALIZADO (TIPO 061/112) PRESENTAN UN MAYOR PORCENTAJE DE INCIDENTES DE SEGURIDAD EN EL ENTORNO DE EMERGENCIAS?

- A. Estudio Nacional de Efectos Adversos en centros hospitalarios (ENEAS).
- B. Estudio APEAS.
- C. Estudio EVADUR.
- D. Informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos (IOM).

Respuesta correcta: C

Comentario:

Las conclusiones del estudio EVADUR¹⁵², al determinar que aquellas personas que fueron llevadas a urgencias por un sistema medicalizado (tipo 061/112) y/o mediante traslado interhospitalario presentaron un mayor porcentaje de incidentes de seguridad que las que acudieron por medios propios.

PREGUNTA 159

EL CAPÍTULO DE FORMACIÓN DE LA “ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 20-30” SEÑALA QUE, ADEMÁS DE IMPULSAR EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS SEGURAS, LAS ORGANIZACIONES COMPROMETIDAS ORIENTAN SUS ESFUERZOS A AUMENTAR LA FORMACIÓN EN LOS LLAMADOS:

- A. Factores humanos o factores no técnicos.
- B. Factores biomédicos y patofisiológicos.
- C. Factores económicos y de sostenibilidad.
- D. Factores organizativos de Osakidetza.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Las organizaciones comprometidas con la Seguridad del Paciente orientan sus esfuerzos a fomen-

tar la cultura de seguridad en todos los niveles, promover un buen clima de seguridad y aumentar la formación en los llamados factores humanos o factores no técnicos del conjunto de profesionales, además de impulsar el desarrollo de prácticas seguras a nivel de unidades clínicas con el objetivo de mejorar la seguridad de la asistencia.

PREGUNTA 160

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA “ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 20-30” NO ESTÁ RELACIONADA CON EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DEL MEDICAMENTO?

- A. L5. Conciliación de la medicación.
- B. L14. Buenas prácticas asociadas a la utilización de medicación.
- C. L6. Optimización en la prescripción de pruebas diagnósticas que utilizan radiación ionizante.
- D. L7. Seguridad transfusional (Nota: la seguridad transfusional se considera una línea separada, aunque implica la administración de productos sanguíneos).

Respuesta correcta: C

Comentario:

En la L7, seguridad transfusional: En la actualidad nos encontramos pendientes de la trasposición de la nueva directiva europea relativa a la instauración de medidas de producción e inspección muy similares a las vigentes en la industria farmacéutica. El riesgo de transmisión infecciosa a través de plaquetas se verá aún más minimizado tras la puesta en marcha de técnicas de reducción de patógenos (tratamiento con amotosaleno e irradiación lumínica). En la L6 no hay ninguna referencia a fármacos.

PREGUNTA 161

SEGÚN EL DIAGNÓSTICO DEL II PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN OSAKIDETZA, ¿QUÉ PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES, RESPECTIVAMENTE, COMPONÍA LA PLANTILLA TOTAL DE OSAKIDETZA EN ENERO DE 2025?

- A. 60% mujeres y 40% hombres
- B. 75% mujeres y 25% hombres

- C. 80% mujeres y 20% hombres
- D. 90% mujeres y 10% hombres

Respuesta correcta: C

Comentario:

- Mujeres 34.288 80,13 %
- Hombres 8.503 19,87 %

PREGUNTA 162

UNA DE LAS METAS DEL II PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN OSAKIDETZA ES LA “CAPACITACIÓN EN IGUALDAD”. ¿CUÁL ES SU OBJETIVO PRINCIPAL?

- A. Reducir la brecha de género en investigación en un 4%.
- B. Conseguir que todas las personas trabajadoras de Osakidetza conozcan el Plan y el Protocolo de Acoso.
- C. Reducir a la mitad las categorías con brecha retributiva superior al 5%.
- D. Garantizar la formación básica, progresiva, permanente y obligatoria de todo el personal de Osakidetza.

Respuesta correcta: D

Comentario:

CAPACITACIÓN EN IGUALDAD: Garantizar la formación básica, progresiva, permanente y obligatoria de todo el personal de Osakidetza.

PREGUNTA 163

¿QUÉ INSTITUCIÓN APRUEBA EL II PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN OSAKIDETZA (2025-2028)?

- A. Mesa Sectorial de Sanidad.
- B. Emakunde.
- C. Consejo de Administración de Osakidetza.
- D. Dirección General de Osakidetza.

Respuesta correcta: C

Comentario:

FASE VII. APROBACIÓN DEL II PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN OSAKIDETZA 2025 – 2028

- Aprobación por parte del Consejo de Administración de Osakidetza: Julio 2025

PREGUNTA 164

DE ACUERDO CON EL II PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN OSAKIDETZA (2025-2028), ¿QUÉ CONCEPTO DEFINE, DENTRO DEL DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN, LA DIFICULTAD INVISIBLE QUE ENCUENTRAN LAS MUJERES PARA ACCEDER A PUESTOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD Y TOMA DE DECISIONES?

- A. Segregación horizontal.
- B. Suelo pegajoso.
- C. Brecha salarial técnica
- D. Techo de cristal.

Respuesta correcta: D

Comentario:

SEGREGACIÓN VERTICAL: Según el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, la segregación vertical se refiere a la distribución de la plantilla en los puestos de distinto nivel de responsabilidad en función del sexo para identificar la existencia, en su caso, de una infrarrepresentación de mujeres en los puestos intermedios o superiores.

SEGREGACIÓN HORIZONTAL: Según el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, la segregación horizontal se refiere a la distribución de la plantilla en la empresa, midiendo el grado de masculinización o feminización que caracteriza cada área.

PREGUNTA 165

UNA DE LAS METAS DEL II PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN OSAKIDETZA (2025-2028) ES “CORRESPONSABILIDAD”. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO ESPECÍFICO ASOCIADO A ESTA META?

- A. Reducir el porcentaje de hombres en puestos de dirección.
- B. Reducir a la mitad la brecha de género en investigación.
- C. Reducir, al menos, en un 2% la brecha de género existente en las medidas de conciliación para cuidados.

D. Aumentar el número de investigaciones con perspectiva de género interseccional en un 4%.

Respuesta correcta: C

Comentario:

CORRESPONSABILIDAD: Reducir, al menos en un 2 % la brecha de género existente en las medidas de conciliación para cuidados (reducciones de jornada y excedencias)”.

PREGUNTA 166

¿CUÁL FUE EL OBJETIVO DEL I PLAN DE IGUALDAD, TENIENDO EN CUENTA SU CONDICIÓN DE PRIMER PLAN ESTRATÉGICO DE OSAKIDETZA EN ESTA MATERIA?

- A. Consolidar los avances logrados y profundizar el proceso transformador.
- B. Establecer unos cimientos sólidos para garantizar el cumplimiento de la legislación y la alineación a los marcos estratégicos.
- C. Reducir la brecha salarial a la mitad en todas las categorías profesionales.
- D. Lograr la aprobación por parte del Consejo de Dirección de Osakidetza en julio de 2025.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Debido a su condición de primer plan estratégico, los esfuerzos estuvieron dirigidos inicialmente al establecimiento de unos cimientos sólidos, garantizando además el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad y la alineación a los marcos estratégicos corporativos.

PREGUNTA 167

¿CUÁL ES LA META 5 ESTABLECIDA EN EL II PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN OSAKIDETZA (2025-2028)?

- A. Reducir la brecha de género existente en las medidas de conciliación para cuidados.
- B. Capacitación en Igualdad, garantizando la formación progresiva del personal.
- C. Igualdad Salarial, con el objetivo de reducir a la mitad las categorías que tienen una brecha retributiva > 5%.

D. Investigación, aumentando el número de investigaciones con perspectiva de género.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Meta 5. IGUALDAD SALARIAL. Reducir, a la mitad, las categorías que tienen una brecha retributiva > 5 %.

PREGUNTA 168

EN RELACIÓN CON LA VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES, EL PLAN II PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN OSAKIDETZA (2025-2028) ESTABLECE COMO LÍNEA DE ACTUACIÓN PRIORITARIA:

- A. El refuerzo de la prevención, la detección precoz y la mejora de la respuesta asistencial integrada desde el sistema de salud.
- B. La derivación inmediata de cualquier caso detectado a servicios jurídicos externos, sin intervención del personal sanitario.
- C. La creación de un registro anónimo donde las personas profesionales puedan denunciar conductas sin seguimiento posterior.
- D. La limitación de la atención asistencial únicamente a las consecuencias físicas derivadas de la violencia.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Meta 10. RECHAZO A LA VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES Y ATENCIÓN INTEGRAL. Conseguir que todas las personas trabajadoras de Osakidetza consideren inaceptable la violencia machista contra las mujeres, y aumentar la detección de los casos en todos los ámbitos, garantizando la continuidad asistencial. Detectar de forma precoz la violencia machista contra las mujeres y garantizar la continuidad asistencial.

PREGUNTA 169

EL III PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZA 2022-2028 ESTABLECE RESPECTO A LOS MENSAJES AUDIOVISUALES QUE:

- A. Deben emitirse en la lengua que decidan las personas responsable de las unidades que utilizan estos sistemas audiovisuales.
- B. Deben emitirse en las dos lenguas oficiales, primero en castellano y luego en euskera.
- C. Deben emitirse en las dos lenguas oficiales, primero en euskera y luego en castellano.
- D. Deben emitirse en una de las dos lenguas oficiales.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Mensajes audiovisuales. Los mensajes que se transmitan a través de sistemas de audio o de pantallas (megafonía, contestadores, pantallas de turno...) deben emitirse en las dos lenguas oficiales, primero en euskera y luego en castellano.

PREGUNTA 170

DE ACUERDO CON EL III PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZA 2022-2028, SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:

- A. Por aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales no puede constar en los datos personales de cada paciente de Osakidetza su idioma de preferencia para las comunicaciones con Osakidetza.
- B. El signo azul con la letra e indica que la persona paciente no tiene competencia para comunicarse en un idioma que no sea el euskera para las comunicaciones orales con Osakidetza.
- C. En los datos personales de cada paciente, se registrará su idioma de preferencia para las comunicaciones orales con Osakidetza.
- D. A las personas que elijan el euskera como lengua prioritaria en sus comunicaciones con Osakidetza solo se les deberá ofrecer servicios en euskera.

Respuesta correcta: C

Comentario:

En los datos personales de cada paciente, se registrará su idioma de preferencia para las comunicaciones orales con Osakidetza.

PREGUNTA 171

EN ATENCIÓN AL III PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZA 2022-2028, SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:

- A. "Aukeratu zeure hizkuntza/Elige tu lengua" es el lema de la campaña de activación del registro de la lengua preferente de cada paciente llevada a cabo en 2017.
- B. Se atribuye a todas las direcciones y gerencias de Osakidetza la responsabilidad de realizar la campaña con el lema "Aukeratu zeure hizkuntza/Elige tu lengua".
- C. "Aukeratu zeure hizkuntza/Elige tu lengua" es el lema de la campaña de activación del registro de la lengua preferente de cada paciente que realizará Osakidetza durante el primer año de planificación.
- D. "Aukeratu zeure hizkuntza/Elige tu lengua" es el lema de la campaña de activación del registro de la lengua preferente de cada paciente que realizará Osakidetza durante el tercer año de planificación.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Según el III Plan de Normalización del Uso del Euskera en Osakidetza 2022-2028 (punto 2.2.2), el lema "Aukeratu zeure hizkuntza/Elige tu lengua" corresponde a la campaña de activación del registro de la lengua preferente llevada a cabo en 2017 (opción A). El plan establece que durante el primer año de planificación se realizará una campaña similar a aquella, pero en el momento de su publicación no se había decidido aún el nombre de la nueva campaña. La coincidencia de nombre fue posterior. Por tanto, la respuesta correcta según el texto literal del plan es la A.

No obstante, esta pregunta ya fue impugnada con éxito en una convocatoria anterior y Osakidetza la retiró. Si vuelve a aparecer con la misma redacción, se recomienda impugnarla, ya que la opción C (primer año de planificación) induce a confusión precisamente porque al final la campaña se ejecutó con el mismo lema, algo que no estaba recogido en el plan en el momento de su publicación.

PREGUNTA 172

EL III PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZA 2022-2028 CONTEMPLA QUE TANTO EN LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y ADMISIÓN, COMO EN LAS UNIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS A TODA LA CIUDADANÍA VASCOHABLANTE DEBE GARANTIZARSE:

- A. La recepción en euskera.
- B. La recepción en euskera solo cuando la comunicación oral con pacientes y personas usuarias sea de modo presencial.
- C. La recepción en euskera solo cuando la comunicación con pacientes y personas usuarias sea telefónicamente.
- D. La recepción en euskera solo por las y los empleados que sepan en euskera.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Bien sea de modo presencial o por teléfono, tanto en los servicios de recepción y admisión, como en las unidades asistenciales y administrativas, debe garantizarse la recepción en euskera a toda la ciudadanía vascohablante.

PREGUNTA 173

EL III PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZA 2022-2028 ESTABLECE QUE, EN LOS ESCRITOS INDIVIDUALIZADOS DE RESPUESTA A SOLICITUDES Y RECLAMACIONES DE PACIENTES O PERSONAS USUARIAS DE OSAKIDETZA SE UTILIZARÁ:

- A. La lengua utilizada por cada ciudadano o ciudadana.
- B. Siempre el euskera como lengua preferente.
- C. Siempre las dos lenguas oficiales independientemente de la lengua utilizada por cada ciudadano o ciudadana.
- D. Ambas lenguas oficiales, siendo los escritos contestados primero en euskera y luego en castellano.

Respuesta correcta: A

Comentario:

En los escritos individualizados de respuesta a solicitudes y reclamaciones de pacientes y personas usuarias, se utilizará la lengua utilizada por cada ciudadano o ciudadana.

PREGUNTA 174

SIGUIENDO LO PREVISTO EN EL III PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZA 2022-2028, SEÑALE LA RESPUESTA QUE NO ES CORRECTA:

- A. Se pondrá a disposición del personal bilingüe que lo desee diferentes elementos identificativos portadores del círculo azul con la letra e, signo que invita a relacionarse en euskera.
- B. El signo azul y la letra e solo se utilizará para la identificación individual del personal bilingüe.
- C. En los centros de salud, consultorios y unidades hospitalarias, deberá estar colocado, de modo visible, el cartel que explica a las personas usuarias el significado del signo identificativo con la letra e.
- D. Se estudiará introducir una variante del círculo azul con la letra e para el personal dispuesto a que le hablen en euskera pero que muestra dificultades para expresarse en ciertas situaciones.

Respuesta correcta: B

Comentario:

En el caso de las personas que elijan el euskera como lengua prioritaria, tanto en su ficha de paciente en las aplicaciones asistenciales, como en otras aplicaciones y elementos identificativos (pulseras, etc.), se mostrará el signo azul con la letra e, que indica preferencia del euskera. De cara a que las personas usuarias vascohablantes conozcan con facilidad con qué profesionales pueden relacionarse en euskera, se pondrán a disposición del personal bilingüe que lo desee diferentes elementos identificativos portadores del círculo azul con la letra e, signo que invita a relacionarse en euskera. Cada profesional utilizará el soporte identificativo más adecuado a su trabajo. En SAP se hará un registro del personal identificado.

Asimismo, se estudiará introducir una variante de este signo para el personal dispuesto a que le hablen en euskera pero que muestra dificultades para expresarse en ciertas situaciones. En los centros de salud, consultorios y unidades hospitalarias, deberá estar colocado, de modo visible, el cartel que explica a las personas usuarias el significado del signo identificativo con la letra e.

PREGUNTA 175

EN ATENCIÓN A LO PREVISTO EN EL III PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZA 2022-2028, EN TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA HA DE PONERSE EN MARCHA UN PROCEDIMIENTO PARA QUE, EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES, SE PROPONGAN SERVICIOS EN EUSKERA A LAS PERSONAS PACIENTES QUE HAYAN REGISTRADO ESTA LENGUA COMO PREFERENTE Y QUE AÚN RECIBAN LOS CITADOS SERVICIOS EN CASTELLANO. SEÑALE A QUÉ SERVICIOS SE REFIERE EL CITADO PLAN:

- A. Medicina familiar, pediatría, enfermería y salud mental.
- B. Pediatría, medicina familiar y salud mental.
- C. Medicina familiar, pediatría, enfermería y matrona.
- D. Todas las anteriores respuestas son correctas.

Respuesta correcta: C

Comentario:

En todos los centros de atención primaria ha de ponerse en marcha un procedimiento (formación de parejas asistenciales euskaldunes, revisión de cupos, oferta activa...), a través del cual, en la medida de las posibilidades, se propongan servicios de medicina familiar, pediatría, enfermería y matrona en euskera a las y los pacientes que hayan registrado esta lengua como preferente y que aún reciban los citados servicios en castellano.

PREGUNTA 176

CONFORME AL III PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZA 2022-2028:

- A. En los casos de los mensajes SMS que se envían a los teléfonos móviles de personas tra-

bajadoras o candidatas, estarán escritos en las dos lenguas oficiales, primero en castellano y luego en euskera.

- B. Los escritos individualizados de respuesta a solicitudes y reclamaciones de las personas trabajadoras deberán redactarse en las dos lenguas oficiales.
- C. Osakidetza ha de garantizar que la información y los servicios ofrecidos tanto al personal empleado como a personas candidatas a través de las tecnologías de la comunicación estén en las dos lenguas oficiales, con el fin de que cada persona haga uso de la lengua de su preferencia.
- D. Las informaciones y comunicaciones no personalizadas dirigidas al personal deberán redactarse en las dos lenguas oficiales y se dará prioridad al castellano.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Relaciones telemáticas con pacientes y personas usuarias. Osakidetza ha de garantizar que la información y los servicios ofrecidos a la ciudadanía a través de las tecnologías de la comunicación (gestiones online de la extranet, Carpeta de Salud, Portal Móvil de Osakidetza, etc.) estén en las dos lenguas oficiales, a fin de que cada persona haga uso de la lengua de su preferencia.

PREGUNTA 177

SEGÚN EL RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL DE EUSKADI (POIE) 2025-2030, ¿DE QUÉ PORCENTAJE DE LOS FALLECIMIENTOS EN EUSKADI FUE RESPONSABLE EL CÁNCER EN EL AÑO 2023?

- A. 22,3%.
- B. Menos del 15%.
- C. 33,8%.
- D. 28%.

Respuesta correcta: D

Comentario:

28% de las defunciones en Euskadi en 2023 se atribuyeron al cáncer.

PREGUNTA 178

SEGÚN EL RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL DE EUSKADI (POIE) 2025-2030, ¿CUÁLES FUERON LAS DOS LOCALIZACIONES DE CÁNCER MÁS FRECUENTES EN EUSKADI EN EL PERIODO 2015-2019, CONSIDERADAS SEPARADAMENTE POR SEXO?

- A. Cáncer colorrectal y cáncer de pulmón.
- B. Cáncer de mama en mujeres y cáncer de próstata en hombres.
- C. Cáncer de páncreas y cáncer de pulmón.
- D. Leucemia y Linfoma de Hodgkin.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Entre 2015 y 2019 se diagnosticaron más de 71.000 nuevos casos de cáncer en Euskadi, con una media anual de 14.327. Las localizaciones más frecuentes fueron el cáncer de mama en mujeres y el de próstata en hombres, seguidos del colorrectal y el de pulmón.

PREGUNTA 179

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES UNA DE LAS ASPIRACIONES DEFINIDAS EN LA VISIÓN DEL PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL DE EUSKADI (POIE) 2025-2030?

- A. Mejorar la calidad de vida de las personas: de pacientes, supervivientes y de sus familiares y personas cuidadoras.
- B. Aumentar la cuota de mercado de Osakidetza en el sector oncológico privado.
- C. Garantizar la presencia equilibrada de ambos sexos en los órganos de gestión sanitaria.
- D. Establecer la telemedicina como la única forma de seguimiento oncológico.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Visión 2030. Mejorar la tasa de supervivencia de las personas con cáncer. Disminuir los años potenciales de vida perdidos por cáncer. Mejorar la calidad de vida de las personas, de pacientes y supervivientes de cáncer, de sus familiares y de

las personas cuidadoras. Mantener y mejorar el compromiso por la equidad. Mejorar la percepción de la ciudadanía en relación con cómo el Sistema aborda el cáncer.

PREGUNTA 180

LA MISIÓN DEL PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL DE EUSKADI (POIE) 2025-2030 BUSCA GENERAR VALOR A LA CIUDADANÍA VASCA EN TÉRMINOS DE:

- A. Mayor financiación externa para I+D.
- B. Menores listas de espera y más personal asistencial.
- C. Mejores resultados en salud.
- D. Una mayor supervivencia a los 10 años en todos los tumores.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Misión. Establecer una estrategia integral, participativa, sostenible y dinámica, que guíe las actuaciones en cáncer en base a la excelencia, la evidencia científica, y la equidad, generando valor a la ciudadanía vasca en términos de mejores resultados en salud.

PREGUNTA 181

EN EL PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL DE EUSKADI (POIE) 2025-2030, LA "CENTRALIDAD DE LA PERSONA Y HUMANIZACIÓN" COMO PRINCIPIO RECTOR INCLUYE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA ATENCIÓN A:

- A. La telemonitorización avanzada.
- B. La diversidad.
- C. El personal profesional no implicado directamente.
- D. Las redes sociales.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Perspectiva de género, asegurando que las intervenciones sean inclusivas y adaptadas a la diversidad y a las necesidades específica.

PREGUNTA 182

TENIENDO EN CUENTA LA INTRODUCCIÓN Y EL CONTEXTO DEL PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL DE EUSKADI 2025-2030. ¿CUÁL FUE UNA DE LAS PRINCIPALES ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS EN LA EVALUACIÓN DEL PLAN ONCOLÓGICO DE EUSKADI (POE) 2018- 2023?

- A. La excesiva visibilidad del plan entre profesionales sin implicación.
- B. La necesidad de aumentar el número de Comités de Tumores.
- C. La necesidad de reforzar la atención a colectivos específicos (infancia, mayores, personas largas supervivientes).
- D. La ausencia total de un modelo asistencial común.

Respuesta correcta: C

Comentario:

La evaluación del POE, en 2023, concluyó que más del 80% de los objetivos fueron alcanzados. Aunque se identificaron algunos ámbitos de mejora como:

- La necesidad de reforzar la atención a colectivos específicos (niños, mayores, largos supervivientes).
- La revisión de la gobernanza y la figura de coordinación del POE.
- La falta de un cuadro de mando para el seguimiento del plan.
- La escasa visibilidad del plan entre profesionales no directamente implicados.

PREGUNTA 183

SEGÚN EL LISTADO DE ACRÓNIMOS DEL PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL DE EUSKADI (POIE) 2025-2030, ¿A QUÉ HACEN REFERENCIA LAS SIGLAS PROMS?

- A. Plan de Resultados Oncológicos y Metodología de Seguimiento.
- B. Plan de Riesgos Ocupacionales en Medicina Sanitaria.
- C. Programa de Rehabilitación Oncológica y Mejora de la Supervivencia.
- D. Medidas de Resultados Reportadas por los y las Pacientes.

Respuesta correcta: D

Comentario:

PROMs Medidas de Resultados Reportadas por los y las Pacientes.

PREGUNTA 184

EL PLAN ONCOLÓGICO INTEGRAL DE EUSKADI (POIE) 2025-2030 SE ALINEA CON EL PLAN DE SALUD DE EUSKADI 2030. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES UNA DE LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE DICHO PLAN DE SALUD MENCIONADAS EN EL DOCUMENTO?

- A. Creación de una red de servicios privados de salud.
- B. Aumentar la esperanza de vida a 90 años.
- C. Reducir la morbilidad evitable y disminuir las desigualdades en salud
- D. Eliminación total del cáncer infantil antes de 2030.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Una de las prioridades del Plan de Salud Euskadi 2030 es mejorar la salud y reducir la morbilidad evitable, además de disminuir las desigualdades en salud.

PREGUNTA 185

¿CUÁL ES EL OBJETO FUNDAMENTAL DE LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA, SEGÚN SU ARTÍCULO 1?

- A. Regular los cuidados paliativos avanzados en el Sistema Nacional de Salud.
- B. Modificar el Código Penal para despenalizar la asistencia al suicidio.
- C. Regular el derecho de toda persona a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir y la obligación de las Administraciones de garantizarla.
- D. Establecer el registro de las voluntades anticipadas y testamentos vitales.

Respuesta correcta: C

Comentario:

El objeto de esta Ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las

condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse.

PREGUNTA 186

CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA, ¿QUÉ REQUISITO DE NACIONALIDAD SE EXIGE PARA PODER RECIBIR LA PRESTACIÓN DE AYUDA PARA MORIR?

- A. Tener la ciudadanía española con residencia legal ininterrumpida de al menos 10 años.
- B. Tener la nacionalidad española o tener residencia legal en España de al menos 5 años.
- C. Ser mayor de edad y tener la nacionalidad española, residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia superior a 12 meses en territorio español.
- D. Tener la nacionalidad española y residencia en el mismo municipio durante los últimos 2 años.

Respuesta correcta: C

Comentario:

a) Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.

PREGUNTA 187

SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA, ¿QUÉ CONCEPTO DEFINE LA LEY COMO LA “ADMINISTRACIÓN DIRECTA A LA PERSONA PACIENTE DE UNA SUSTANCIA POR PARTE DEL PERSONAL SANITARIO COMPETENTE”?

- A. Suicidio médicamente asistido.
- B. Sedación paliativa profunda.
- C. Eutanasia.
- D. Asistencia para morir.

Respuesta correcta: D

Comentario:

g) «Prestación de ayuda para morir»: acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos en esta Ley y que ha manifestado su deseo de morir. Dicha prestación se puede producir en dos modalidades: 1.ª) La administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente. En los casos en los que la prestación de ayuda para morir lo sea conforme a la forma descrita en el artículo 3.g.1.ª) el médico responsable, así como el resto de profesionales sanitarios, asistirán al paciente hasta el momento de su muerte.

PREGUNTA 188

SEGÚN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA, ¿CUÁL ES LA CONDICIÓN QUE DEBE PADECER LA PERSONA PACIENTE PARA SOLICITAR LA PRESTACIÓN DE AYUDA PARA MORIR?

- A. Padecer una enfermedad incurable en fase terminal o un deterioro funcional grave.
- B. Sufrir una enfermedad que limite gravemente su autonomía.
- C. Padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, causantes de un sufrimiento intolerable.
- D. Sufrir un dolor físico o psíquico que no puede ser tratado con paliativos.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable.

PREGUNTA 189

SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA, ¿CUÁL DEBE SER LA PERIODICIDAD MÍNIMA CON LA QUE EL PERSONAL FACULTATIVO RESPONSABLE DEBE CONSULTAR A LA PERSONA PACIENTE, UNA VEZ

PRESENTADA LA SOLICITUD, PARA CONFIRMAR SI MANTIENE SU DESEO?

- A. Al menos cada 7 días.
- B. Al menos cada 15 días, debiendo dejarse constancia en la historia clínica.
- C. Al menos cada 30 días, si el procedimiento se extiende.
- D. Una única vez antes de la prestación.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas.

PREGUNTA 190

SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA, ¿CUÁL ES EL DERECHO QUE ASISTE AL PERSONAL SANITARIO DIRECTAMENTE IMPLICADO EN LA PRESTACIÓN DE AYUDA PARA MORIR?

- A. Derecho a la reubicación en un puesto de trabajo diferente.
- B. Derecho a un incremento salarial por la complejidad de la prestación.
- C. Derecho a la objeción de conciencia.
- D. Derecho a recibir asistencia jurídica de oficio.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

PREGUNTA 191

SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA, ¿QUÉ DEFINE COMO “PADECIMIENTO GRAVE, CRÓNICO E IMPOSIBILITANTE”?

- A. Aquel que implica la existencia de sufrimiento físico o psíquico constante.
- B. Aquel que genera una limitación que incide direc-

tamente sobre la autonomía física y capacidad de expresar su voluntad de la persona paciente.

- C. La dependencia de otra persona para la realización de al menos dos actividades básicas de la vida diaria.
- D. Una dolencia que ha sido declarada irreversible y con un pronóstico de vida inferior a seis meses.

Respuesta correcta: B

Comentario:

«Padecimiento grave, crónico e imposibilitante»: situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico.

PREGUNTA 192

SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA, ¿CUÁL ES EL PLAZO QUE TIENE LA PERSONA FACULTATIVA RESPONSABLE PARA COMUNICAR LA RESOLUCIÓN FAVORABLE A LA COMISIÓN DE GARANTÍA Y EVALUACIÓN PARA SU POSTERIOR VERIFICACIÓN?

- A. Dentro de las 24 horas siguientes a la resolución.
- B. Dentro del día siguiente natural a la resolución.
- C. 7 días desde la resolución favorable.
- D. No existe un plazo establecido para esta comunicación.

Respuesta correcta: C

Comentario:

Ninguna opción recoge el plazo real (3 días hábiles del art. 8.5 LO 3/2021). C es la menos mala porque 7 días sí es un plazo que aparece en la ley. Marca C aunque la pregunta es impugnada.

PREGUNTA 193

¿CUÁL ES EL PRINCIPIO GENERAL QUE ESTABLECE LA LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS?

- A. La libre acumulación de empleos públicos.
- B. La incompatibilidad para desempeñar más de un puesto en el sector público, salvo excepciones.
- C. La compatibilidad automática entre empleo público y privado.
- D. La compatibilidad solo en el ámbito sanitario.

Respuesta correcta: B

Comentario:

El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma.

PREGUNTA 194

CON CARÁCTER GENERAL, EL PERSONAL COMPRENDIDO EN LA LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PODRÁ DESEMPEÑAR:

- A. Dos puestos públicos si uno es a tiempo parcial.
- B. Un segundo puesto público únicamente con autorización previa y en los supuestos previstos por la Ley.
- C. Cualquier actividad privada sin limitación.
- D. Dos puestos públicos si pertenecen a distinta Administración.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Con carácter general no se puede desempeñar un segundo puesto público; solo se puede en los supuestos expresamente establecidos en la ley y con autorización previa.

PREGUNTA 195

SEGÚN LA LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ¿QUÉ REQUISITO ES IMPRESCINDIBLE PARA AUTORIZAR LA COMPATIBILIDAD CON UNA ACTIVIDAD PRIVADA?

- A. Que la actividad sea sanitaria.
- B. Que no se supere la jornada ordinaria establecida.
- C. Que no se comprometa la imparcialidad o independencia del personal público.
- D. Que lo autorice la jefatura inmediata sin más trámites.

Respuesta correcta: C

Comentario:

El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.

PREGUNTA 196

SEGÚN LA LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ¿PUEDE PERCIBIRSE MÁS DE UNA REMUNERACIÓN CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS?

- A. Sí, siempre que no superen el salario mínimo.
- B. No, salvo en los casos expresamente previstos en la Ley.
- C. Sí, sin limitación alguna.
- D. Solo si se trata de diferentes Administraciones autonómicas.

Respuesta correcta: B

Comentario:

Las actividades privadas solo pueden compatibilizarse con el empleo público en los casos expresamente previstos en la Ley 53/1984 y con autorización previa. Será requisito necesario para autorizar la compati-

lidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en los porcentajes establecidos por la Ley.

PREGUNTA 197

SEGÚN LA LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ¿QUÉ OCURRE SI SE DESEMPEÑA UNA ACTIVIDAD INCOMPATIBLE SIN AUTORIZACIÓN?

- A. No ocurre nada si es fuera del horario laboral.
- B. Se considera falta leve.
- C. Puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria.
- D. Solo se devuelve la remuneración percibida.

Respuesta correcta: C

Comentario:

El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores será sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido.

PREGUNTA 198

SEGÚN LA LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ¿QUÉ ACTIVIDADES ESTÁN EXCEPTUADAS DEL RÉGIMEN GENERAL DE INCOMPATIBILIDADES?

- A. Las actividades docentes o de investigación en determinados supuestos.
- B. Cualquier actividad privada.
- C. Solo actividades artísticas.
- D. Actividades comerciales propias sin límite.

Respuesta correcta: A

Comentario:

Al personal docente e investigador de la Universidad podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en

el sector público sanitario o de carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial.

PREGUNTA 199

SEGÚN LA LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARA QUE SE AUTORICE LA COMPATIBILIDAD PARA UN SEGUNDO PUESTO PÚBLICO ES NECESARIO QUE:

- A. Sea en el mismo centro de trabajo.
- B. Sea la jornada completa.
- C. Sea en los supuestos tasados y no se modifique la jornada y horario del puesto principal.
- D. Lo apruebe el personal trabajador del servicio.

Respuesta correcta: C

Comentario:

El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma. Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

PREGUNTA 200

LA FINALIDAD PRINCIPAL DE LA LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ES:

- A. Incrementar los ingresos del personal público.
- B. Garantizar la dedicación y la imparcialidad en el servicio público.

- C. Permitir la pluriactividad generalizada.
- D. Reducir el número de personal público.

Respuesta correcta: B

Comentario:

La finalidad principal de la Ley 53/1984 es garantizar la dedicación plena y la imparcialidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, evitando conflictos de interés. La nueva regulación de las incompatibilidades contenida en esta Ley parte, como principio fundamental, de la dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.



www.salusplay.com